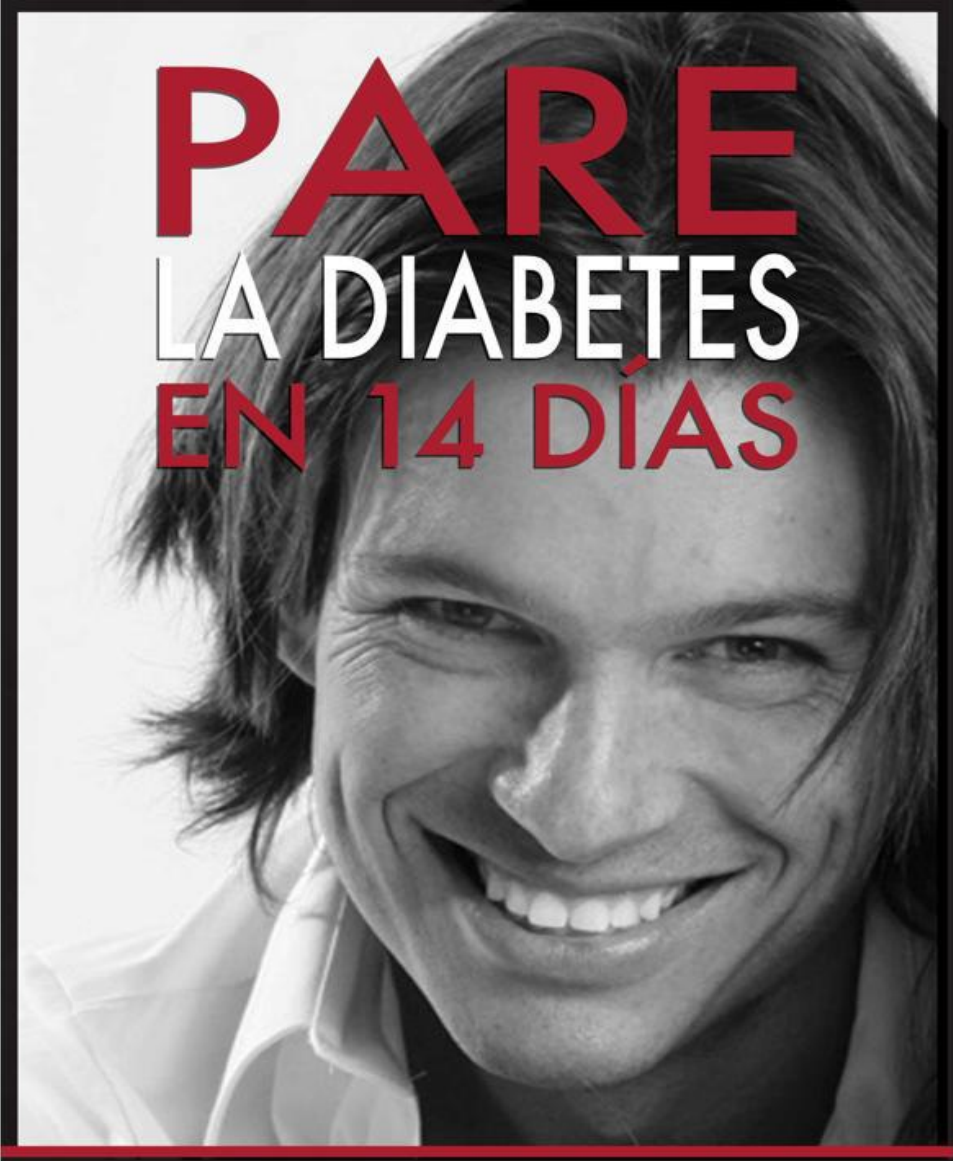
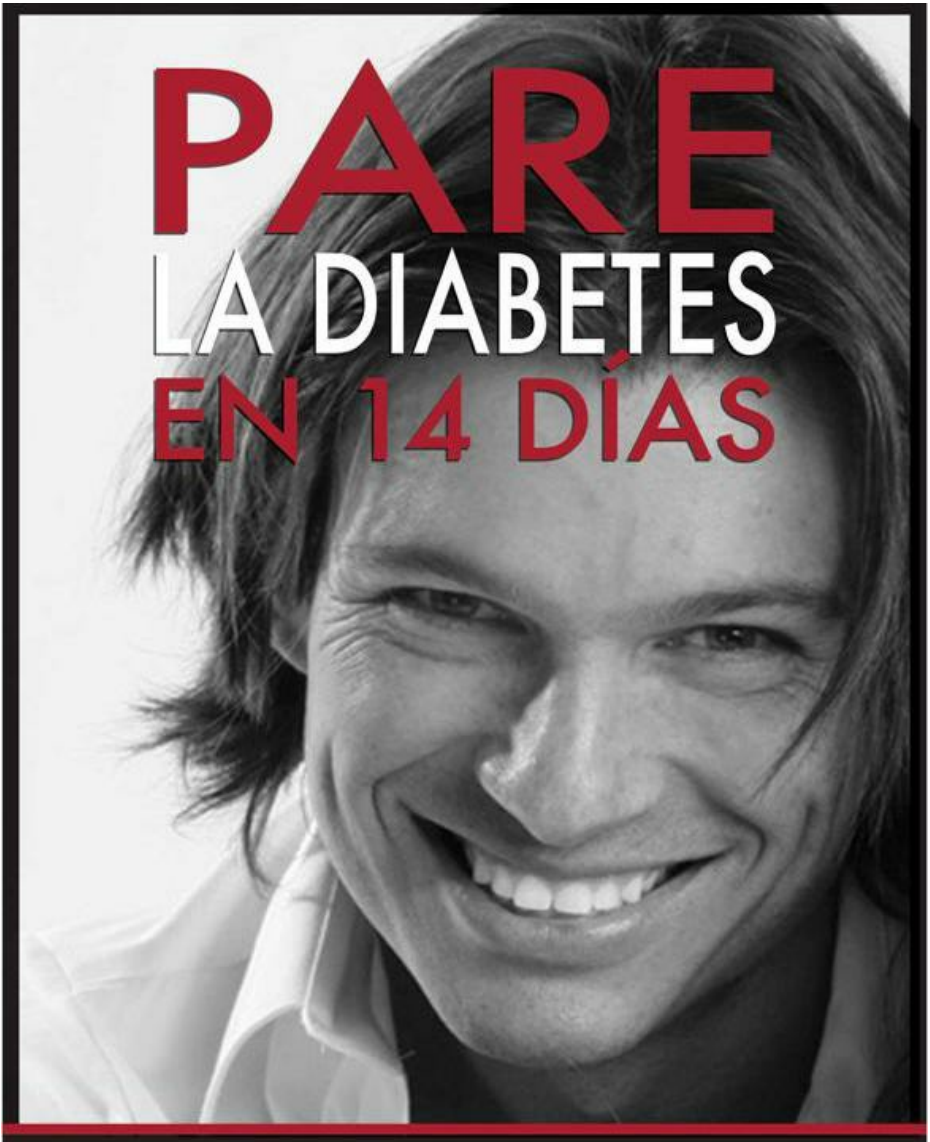
PARE LA DIABETES EN 14 DÍAS



Dr. LUDWIG JOHNSON

PARE LA DIABETES EN 14 DÍAS



Dr. LUDWIG JOHNSON

PARE LA DIABETES En 14 Días

Dr. Ludwig Johnson

NOTA DEL AUTOR

El presente libro no sustituye bajo ningún concepto la atención médica personalizada. Usted debe consultar a su médico antes de tomar cualquier acción sugerida en este o en cualquier otro libro. Ni el autor, ni quien publica, se hacen responsables de las acciones emprendidas por el lector.

Pare la Diabetes en 14 días.
Dr. Ludwig Johnson.
Caracas. Venezuela, 2011.

Reservados todos los derechos. Queda terminantemente
prohibida, sin la autorización escrita del autor bajo las sanciones
establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total
de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos
la reprografía y el tratamiento informático.

Hecho el Depósito de Ley
Depósito Legal:
ISBN:
ISBN: 9781618429858

Diseño Gráfico: Florencia Zabala.
Fotografía de Portada: Daniel Alonso.

Impreso por: Tipografía Chacao, C.A.

Dedicatoria

A Maya,
por mostrarme el cielo.
Y a John.
por mostrármelo otra vez.
Dios los bendiga.

Agradecimientos

A mis pacientes con diabetes y a mis pacientes ahora sin medicinas, que nunca dudaron en regalar sus testimonios grabados en videos. Ustedes han sido el único motivo para que muchos médicos cuestionaran el status quo. En nombre de todos, y muy especialmente en nombre de tantos que ya no sufrirán, gracias. Sin ustedes, la tarea hubiese sido imposible.

Y a la vida. A la fuerza que lo mueve y lo promueve y lo conecta todo. Gracias por el ardor en el pecho que nunca calmó hasta escribir este libro.

A USTED QUE NO LO CONOZCO

No se quién es usted. Pero dos cosas nos unen. Su deseo por sanar y mi deseo porque sane. Porque pueda frenar lo que causa la diabetes en su cuerpo, y no solamente las consecuencias que la diabetes causa en su cuerpo. Como le digo, no lo conozco. Y no sé en qué momento este libro ha caído en sus manos. ¿Con pocos meses de diabetes? ¿Adentrado en ella? ¿Con la neuropatía o la retinopatía o la nefropatía en usted? PARE LA DIABETES no es un milagro. Es la consecuencia lógica de atacar el problema y no las consecuencias del problema con el tratamiento farmacológico que no produce daños peores. Por ello se eliminan medicinas. Por ello se reducen cantidades. Y por ello se evitan nuevas por tomar. Con PARE LA DIABETES aquellos jóvenes obesos y con pocos meses del diagnóstico podrán revertir completamente la enfermedad. En otros, la reversión será el alivio de algún síntoma, la preservación de la independencia, o la ausencia un mal mayor (como bien podrá ver en los videotestimonios www.drludwigjohnson.com). Sea como fuere, este libro le dará vida. Y juntos haremos que la verdad, sepultada por los intereses de unos pocos con poder, sea escuchada por un planeta que le urge dar el cambio. No lo conozco. Pero usted es como mi abuelo. Como mi padre. Como mi hermano. Usted es mi familia. Y aunque no lo pueda ver, ni tocar, ni hablarle siquiera, al menos usted, si que podrá llevarle este libro a su médico.

Hágalo. En el capítulo 5 he incluido una guía especialmente diseñada para él o ella, donde le llevo de la mano paso a paso por los primeros 14 días de su nuevo tratamiento. Mire que a partir de ahora, ambos le vamos a ayudar. Y escríbame. Tal vez sea su historia la que algún día motive a muchos. Cuídese y hasta pronto. Lo quiero mucho.

Dr. Ludwig Johnson

Todos somos criaturas del hábito, particularmente los médicos, quienes, por multiplicidad de razones, tendemos a pensar en patrones reiterativos basados en modelos convencionales. Sin embargo, los avances significativos rara vez ocurren siguiendo el status quo. Ir más allá siempre requiere del análisis para reconocer las ideas correctas, la justificación científica para implementarlas, y el coraje para seguirlas a pesar de la vigoroza oposición. Los conceptos aquí descritos serán eventualmente aceptados como obvios y universalmente implementados. Los lectores de este volumen tendrán el privilegio de recoger sus beneficios y prolongar sus vidas y la de los suyos, al pasar este conocimiento a las futuras generaciones.

Harvey S. Hecht, M.D., F.A.C.C
Director of preventive Cardiology,
Beth Israel Medical Center.
En el prefacio del libro
Before the heart attacks.

“En tres semanas suspendí las pastillas de la tensión… increíble, pero eran las que me producían la fatiga”.

Julio 48.
Grupo 2.

“Usted tiene diabetes, me dijo. Me asusté… comencé con el programa y ya tengo 2 años sin diabetes…y sin medicinas”.

Enrique. 42. Hombre de negocios.
Grupo 1.

“Mi médico lo único que hacía era aumentarme la insulina. Yo no veo cuál es el problema, me decía… Estaba harto de pincharme”.

Santiago, 62.
Dejó la insulina.
Grupo 2.

“Perdí más de 20 kilos de pura barriga. Y hasta me curé el hígado graso”.

Andrés. 55. Vendedor de equipos médicos.
15 años con el diagnóstico de diabetes, y padre de 3 con síndrome metabólico.
Grupo 1.

“A los dos días de iniciado el programa, ya mi azúcar estaba bien.”

Santiago, 54.
Revirtió su Gastroparesis.
Grupo 3.

“Comencé a perder peso, por primera vez en años, y se me quitaron los dolores que no me dejaban dormir”.

Catalina. 69. Abuela de 94 kilos. Antes de la insulina 72.
Más de 20 años con el diagnóstico de diabetes.
Grupo 3

“Mi endocrino me mandaba Viagra, pero nada… hasta que un amigo me habló del programa.”

Pedro. 48. Casado y sin hijos
Grupo 1.

“A las dos semanas ya me había quitado 10 cm de cintura, tenía el azúcar bien, y me bajaba la menstruación después de 8 meses de ausencia”.

Andreina. 46.
Dos años con el diagnóstico de diabetes y ex Ovario Poliquístico.
Grupo 1.

“Se me quitaron las ansias por harinas y dulces… y a los dos meses salí embarazada.”

Isabela, 39. Recientemente diagnosticada con diabetes
y más de 10 años en tratamiento por infertilidad.
Grupo 1

“El primer día me suspendió casi todas las medicinas… me mandó a tomar magnesio… me bajaron los triglicéridos, se me quitaron los dolores de cabeza, la tensión se normalizó, el azúcar bien… un milagro”.

Josefina, 38.
Grupo 1.

“Se me quitó la hinchazón y los dolores articulares ... volví a tocar el cuatro”.

Julio, 63. Músico.
Meses con una medicina para su tensión arterial que le retenía líquido
Grupo 3.

“No me operaban la retinopatía por el azúcar. En tres días me estaban operando”.

Claudia, 48.
Grupo 3.

“El cambio fue impresionante. En cuestión de días ya estaba bien. Y con la cantidad de endocrinos a los que había ido… pero nunca, nunca… no fue sino hasta que suspendí el calcio, agregué el magnesio, y paré las medicinas que venía tomando, que sentí la mejoría. Me quité la barriga de toda la vida, imagínate ...mi esposa pensaba que yo tenía una amante”.

Pablo, 38.
Meses con una medicina que le bajaba el azúcar más de lo normal.
Grupo 1

Grupo 1 *Su diabetes apareció antes de los 60 años de edad, con obesidad o sobrepeso.*

Grupo 2 *Su diabetes apareció después de los 60 años de edad.*

Grupo 3 *Su diabetes apareció antes de los 60 años de edad, delgado y con barriga.*

Bienvenido al Programa
de Reversión de la Diabetes
Tipo 2
Dr. Johnson

Atacar
la consecuencia
de la diabetes,
la controla.
Atacar la causa,
la revierte.

A partir de ahora
evitará la necesidad
de nuevas medicinas,
eliminará
parcial o totalmente algunas
de las que ya toma
y recuperará mucho
su vitalidad perdida.

(¿Conoce su Hemoglobina Glicosilada A1c?)

Atención

Este no es un libro sobre lo que ya sabe.
Al contrario, es sobre lo que no sabe
o que piensa que sabe, pero no sabe.
Si está buscando leer
sobre los peligros de la diabetes,
ciérrelo y búsquese otro.
Hay muchos que le complacerán mejor.
Pero si lo que busca es revertir la enfermedad
según sus posibilidades, siga leyendo.
Este libro le puede cambiar la vida.

Si no sabe lo que es la Hemoglobina Glicosilada A1c, ….

CAMBIE
DE
MÉDICO
AHORA MISMO

Ps. La Hemoglobina Glicosilada consiste

en un
examen de sangre que evalúa el grado de
“empatucamiento” que sus órganos han sufrido
por causa de su glicemia o “azúcar” elevado.

INTRODUCCIÓN

Su
Tratamiento
No sirve

7:00 am. Primera glicemia del día, 140 mg/dl. Auch. Ya se empatucaron sus órganos. No importa. Para eso está su Metformina con Glibenclamida (que usualmente le baja el azúcar más allá de lo deseado) o, si su médico se actualiza, Vildagliptina o Sitagliptina, seguido del famélico cereal con fruta o la desabrida tortilla de claras únicamente. Ya desayunado, procede a reducir la retención de líquido con un diurético "suave" que bota Magnesio y, en consecuencia, le aumenta el riesgo de infarto, cáncer y Alzheimer. 7:20 am. Se prepara para su efecto secundario de media mañana. ¿Cuál será hoy? ¿La ansiedad repentina por harinas y dulces? ¿La sensación de bajón a las dos horas del desayuno? ¿O serán sólo calambres en los pies? 9:00 am. "Bajón a las dos horas del desayuno". Está preparado. Fruta nuevamente que, aunque le saca barriga, también le saca de la hipoglicemia que le produce la Glibenclamida o la insulina que se inyecta a primera hora del día. 12:00 pm. Su médico ha prescrito ejercicio. Caminata que inicia con la falta de aliento que le produce el betabloqueante de la noche anterior, pero que combate con su bebida "para diabéticos" (que aporta las mismas calorías que se quita con el ejercicio –DUH–). 1:00 pm. Segunda comida. Para hoy, sopa de celery baja en sal y un sobre de galletas integrales alto

en fibra. Ambos, para acompañar su lata de 120 g de atún y media taza de papa al vapor, que sube la glicemia por encima de 140, y, en consecuencia, empatuca o glicosila los órganos. Para ello, su segunda medicina "para diabetes" del día. ¿Cuál? Nuevamente la Glibenclamida (o si se inyecta, otra vez la insulina). Droga que habrá de nivelar el azúcar elevado por la papa insípida que se acaba de comer, porque si no la come, le da el "bajón". Y su primer betabloqueante. Pastilla que, como hemos dicho, lo marea y fatiga, pero la aguanta porque evita sus taquicardias (pero que el magnesio evitaría). 3:00 pm. "Bajón de azúcar". Hoy fue un día sin papa. Su nutricionista lo regaña. Su médico lo regaña. "Usted necesita carbohidratos. Esas dietas locas de usted. ¿Quiere perder peso? Haga ejercicio. La papa es necesaria. La papa es la energía". Pero a usted, cuando la come, se le "baja la suichera". Le da "como un down", dice usted. Pero si no la come, la Glibenclamida se encarga de que sienta lo mismo. En fin, los médicos sabrán. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Por el bajón de las 3:00 pm. Que rescata con fruta o un chocolatico que le calma "la ansiedad" (el "hambre que no es hambre sino ganas de comer", y que empatuca y saca barriga). 8:00 pm. Cena, y si se inyecta, su penúltima insulina del día. Consomé desgrasado y un plato de avena. Cereal bajo en grasa que a las dos horas eleva su glicemia por encima de 200 y le empatuca los

órganos, para lo cual todo está previamente calculado. Le indicaron Pioglitazona (vaya ahora mismo a que se la suspendan si se inyecta insulina). Medicamento que retiene líquido, aumenta su riesgo de osteoporosis y engorda. Pero corrige su glicemia elevada por el cereal de su nutricionista. Y, finalmente, pastillas para el colesterol y los triglicéridos. La primera, una estatina que le roba 5% de la masa muscular anual. Y aunque el músculo es el único tejido anti diabetes, igual hay que tener el colesterol normal. Y la segunda, un medicamento que "pinta la grieta, pero no repara el tubo roto que produce la filtración", y en consecuencia, baja los triglicéridos, pero mantiene el riesgo a tener el infarto. 10:00 pm. Último betabloqueante del día para enmascarar la deficiencia de magnesio y, en consecuencia, para permitir la producción de cálculos renales, degeneración articular, fatiga, dolores articulares e insomnio. Y que además, como ha descubierto, disminuye el desempeño sexual. Pero para el sexo está muy cansado. Y sin el betabloqueante no podría dormir por las taquicardias que se quitarían con magnesio. 11:00 pm. Hora de dormir. Pastilla para dormir que no fuese necesaria con magnesio (disculpe la redundancia). Se trata de una bensodiazepina que también roba memoria y habilidad cognitiva. Pero hay que dormir. Mañana es un día fuerte. 7:00 am. Primera glicemia del día siguiente. Auch. 140 otra vez.

Empatucado otra vez. No importa otra vez… Para eso, nuevamente, la Metformina con Glibenclamida que le baja el azúcar más allá de lo normal otra vez. O si su médico se actualiza, Vildagliptina o Sitagliptina…

Sólo para médicos

Imagine, hace 40.000 años, a dos grupos de seres humanos metabólicamente contrarios. El primero, capaz de cruzar médanos en ayuno, comer cualquier animal y continuar con la glicemia en rango. Y el segundo, necesitado de alimentos que aportaran rápidamente la glucosa como granos y tubérculos, pero inexistentes para entonces. E imagine, para completar el cuadro, que existían endocrinólogos. ¿De cuál grupo serían los pacientes? Seguro que serían del segundo. Consultarían por irritabilidad, desmayos, tensión baja, pérdida de peso, depresión, fatiga y, finalmente, la muerte. Sus curvas de glicemia a los 0, 8, 12, 16, y 20 horas mostrarían "el azúcar bajo" por un "defecto" en la neoglucogénesis hepática. Y "la industria" fabricaría drogas para "tratar la enfermedad". Luego imagine, transcurridos los 40.000 años, que aparecen granos y tubérculos sobre la tierra. Y que un grupo sana ingiriéndolos. Pero las "academias" no aprueban la medida. Este es el absurdo, ni más ni menos, de lo que actualmente vivimos los inteligentes seres

humanos con la diabetes Tipo 2. Pero al contrario. El grupo enfermo es el primero y no el segundo. Y la solución es retirar los granos y los tubérculos, y no agregarlos. Pero las “academias” no aprueban la medida.

Estimado colega: Los pacientes con diabetes Tipo 2 cuentan con un metabolismo “paleolítico” desde el nacimiento. Esto es, están provistos de un metabolismo cuya principal fuente de energía son las proteínas de la dieta, no los carbohidratos, y que la ciencia denominó insulinorresistencia o resistencia a la insulina. Condición esta que permitió la sobrevivencia hace más de 10.000 años cuando no había agricultura en el planeta. Entender esto, y entender que nuestro genoma no ha cambiado durante los últimos 40.000 años, es entender por qué el nombre del juego en el paciente con diabetes no es “controlar la glicemia”, sino “comer paleolítico y entonces controlar la glicemia”. No debemos olvidar los 4 estudios presentados en el 67avo Congreso de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) de 2010, en los que se muestra el fracaso del tratamiento de la diabetes Tipo 2, muy a pesar de haber controlado la glicemia. El primero, de 5 años de duración, en el que no se encontró la esperada disminución de la macropatía diabética en el grupo de mayor control versus el de menor control. El segundo, denominado ACCORD, suspendido a tres años y medio de su inicio por presentar más fallecimientos en el grupo de mayor control. El tercero

(The Veterans), que consiguió después de 11 años del diagnóstico la misma morbilidad y mortalidad en el grupo de estricto versus el de poco control. Y el cuarto (esta vez británico), que evidenció menor cantidad de complicaciones cardiovasculares en aquellos con moderado versus estricto o mínimo control.

Ver:

http://www.medscape.com/viewarticle/576336

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0808431

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9742976

La explicación de estos resultados "paradójicos", en los que hay más complicaciones con mejor control de la glicemia, nace del equivocado tratamiento de "Las academias" que no reconoce a la resistencia hepática a la insulina como una ventaja, sino como un defecto metabólico. Contrario al siguiente estudio. Que, como verá en su conclusión, lo reconoce como ventaja en un medio paleolítico (paradigma correcto).

Ver:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1875844

Responsable a su vez, esta ventaja paleolítica, de la neoglucogénesis hepática aumentada y sus sinónimos metabólicos, cuando se ingieren alimentos anti paleolíticos. A decir, hiperglicemia basal, hígado graso, grasa abdominal, hipertrigliciridemia, edema, adicción por harinas y dulces, e hipertensión arterial. En aquellos, repito, con el paleo genoma y la dieta moderna (granos, tubérculos y frutas todo el año). Como verá, el próximo estudio contradice el anterior, al concluir que dicha ventaja es un "defecto metabólico" con la alimentación anti paleolítica o moderna.

Ver:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1425161

Decir que el defecto es "el metabolismo paleolítico" (paradigma incorrecto), y no que el defecto es "ingerir alimentos anti paleolíticos cuando se es paleolítico", es decir que la insolación del blanco "es un defecto en su piel" (paradigma incorrecto), y no que su insolación es por "tomar el sol cuando se es blanco" (paradigma correcto). Comprender esto es fundamental para el tratamiento de la diabetes. Note como los siguientes dos estudios insisten con el paradigma incorrecto. Anunciar que la dieta paleolítica mostró ser superior a la mediterránea en aquellos con diabetes y riesgo

cardiovascular, sería como anunciar que un planeta con óxigeno mostró ser superior al sin óxigeno en aquellos con riesgo de afixia. Tal descubrimiento tendría sólo sentido si se pensara que el óxigeno no es lo normal y que la afixia tiene cualquier causa, menos la falta de oxígeno.

Ver:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19604407

http://www.springerlink.com/content/h7628r66r0552222/

Un cavernícola jamás tuvo dos opciones para hacer dieta. Sólo tuvo una opción. La paleolítica. La palabra dieta no aparece en el diccionario cromañón.

Un segundo concepto que debe ser comprendido es el índice glicémico como responsable de la hiperglicemia postprandial. Y no, como suele ocurrir, de la necesidad de indicar nuevas medicinas, en estadíos donde la reserva pancreática lo permite.

Ver:

http://www.mayoclinicproceedings.com/content/79/1/101.

http://www.nutritionandmetabolism.com/content/5/1/36

Una tercera consideración ausente en el tratamiento de las "academias", que también deberá ser comprendida para el correcto tratamiento de la diabetes, es el GAME o Excursión Glicémica como factor de evolución en su desarrollo, aun con la glicemia "controlada" (HbA1c inferior a 6,2%).

Ver:

http://jama.ama-assn.org/content/295/14/1681

http://jama.ama-assn.org/content/303/22/2291.short

Y un cuarto y último factor, tampoco reconocido por el tratamiento de las "academias", es la Hipomagnesemia Intracelular como gestor de la patología cardiovascular, años antes inclusive de que la glicemia se eleve.

Ver:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19124169

http://care.diabetesjournals.org/content/15/7/835

Si el tratamiento no reconoce estos 4 fundamentos, nunca podrá inhibir la neoglucogénesis nocturna aumentada y, en consecuencia, menos podrá liberar a los pacientes del

síndrome metabólico del que se encuentran inmersos, aun con la glicemia controlada.

Ver:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18657678

http://www.medscape.com/viewarticle/538950

http://care.diabetesjournals.org/content/34/Supplement_2/S

Si el tratamiento no reconoce estos principios, menos podrá controlar la hiperglicemia postprandial sin medicamentos que infartan y engordan, y en consecuencia, que evolucionan la enfermedad, aun con la glicemia controlada.

Ver:

http://www.medscape.com/viewarticle/579822

http://www.medscape.com/viewarticle/538950

http://care.diabetesjournals.org/content/34/Supplement_2/S

Si el tratamiento no reconoce la Hipomagnemia Intracelular, los pacientes nunca evitarán la hipertensión en primera instancia, y a pesar de controlarla con

medicinas, menos podrán evitar la mudanza del calcio a los órganos y al endotelio vascular, produciendo calcificación arterial, accidentes cardiovasculares y el sin fin de complicaciones que se producen antes, inclusive, del desarrollo de la diabetes.

Ver:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9056694

En este sentido, de continuar con "tratamientos que no tratan" estos 4 fundamentos, seguiremos con pacientes controlados, pero que igualmente fallecen de infartos y accidentes cardiovasculares, o por el cáncer o el Alzheimer "de la edad". Y en el otro polo, seguiremos con pacientes descontrolados a pesar de cumplir sus tratamientos engordantes, y en consecuencia, productores de diabetes, que siempre enfrentan la devastadora micropatía diabética. Es mi ilusión, amigo colega, que ninguno de estos escenarios sea vivido por sus pacientes. Por eso este libro. Con un protocolo de resultados sorprendentes para aquellos absolutos seguidores de "las pautas de la academia", pero lógicos para aquellos seguidores de la "medicina basada en la evidencia", y seguro que si, también de las "academias". Sea usted bienvenido.

CAPÍTULO 1

¿Recuerda cuando no tenía diabetes?

Era flaco y "con la edad" le salió barriga o era rellenito y engordó "de repente".

Sea como fuere, su metabolismo fue diseñado para vivir en un mundo prehistórico, sin agricultura, y con tierras y aguas cargadas de magnesio. Se nace con un tipo de metabolismo celular "invisible" al examen de sangre, porque la sangre no existe en el interior celular. Si deseáramos evaluarlo, deberíamos sacar líquido del interior de las células. De esta manera, dos personas podrán tener los mismos resultados en sus exámenes, pero con metabolismos diferentes. Metabolismos que corresponden a la adaptación de la especie humana en regiones con o sin frutas, con poco o mucho magnesio, pero siempre sin granos ni tubérculos. Hasta hace 15 segundos. Si tuviéramos 24 horas de historia. Que fue cuando todo cambió. Porque aparecieron los granos y los tubérculos. Que engordan a los cerdos. Y que alteran el metabolsimo de aquelllos con el paleo genoma. Como desde el inicio les hemos llamado. Metabolismo **Tipo 1.** No resistentes a la insulina y alta captación de magnesio. **Tipo 2.** No resistentes a la insulina y baja captación de magnesio. **Tipo 3.** Resistentes a la insulina y alta captación de magnesio. **Tipo 4.** Resistentes a la insulina y

baja captación de magnesio. ¿Cuál es su tipo? Con seguridad 3 ó 4. Desde el nacimiento. Como el color de la piel. Que es negro, blanco, albino o amarillo. Y en consecuencia, ni el color de la piel, ni el metabolismo celular, dependen de los hábitos de vida. Sin embargo, un blanco sufrirá si expone su piel al sol, un negro no. Los resistentes a la insulina sufrirán si comen granos, frutas y tubérculos. Los otros no. El blanco que toma sol, irá al dermatólogo a curar sus ampollas. No a curar su color de piel. La insolación se cura. Pero el color blanco no, porque ser blanco no es una enfermedad. Y por ello no se dice: "Yo tengo blanco". Se dice: "Yo soy blanco". Como tampoco se dice: "Yo tengo resistencia a la insulina". Se dice: "Yo soy resistente a la insulina". Y la resistencia a la insulina no se cura. Porque no es enfermedad. Muy al contrario, como hemos dicho, es una ventaja de adaptación en la era paleolítica. Como la tez negra en geografías de sol. Los esquimales por ejemplo, que son resistentes a la insulina, desayunan foca, almuerzan gaviota y cenan salmón. Y acompañan sus comidas con nieve. Porque en la nieve, sucede, no hay cosecha. Y las personas llegan a 90 como si tuvieran 40. Pero si un esquimal vive en el trópico, donde la alimentación es de granos, tubérculos y frutas, en menos de lo que canta un gallo habrá un paciente con diabetes. ¿Imagina un albino que toma sol? Ya usted comienza a entender el problema. Los granos, harinas, cereales y tubérculos, que la

sociedad le “vendió” como alimentos sanos, son para quienes cuentan con el paleo genoma, como el sol para un albino. En el siguiente estudio se deja claro cómo la alimentación paleolítica lo comenzaría a sanar.

Ver:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19209185

“Yo soy sano”, solía decir. “Mi problema es la barriga”.

Hasta que consiguieron su hígado graso. O su tensión elevada. O sus triglicéridos altos. O sus ovarios poliquísticos. Usted se sorprendió. Porque su glicemia siempre salía “bien”. Estaba pendiente. Creció viendo la diabetes de sus abuelos. Y aprendió a temerle. Pero estaba lejos de ella. Su azúcar estaba “bien”. ¿Correcto?

No. Su azúcar no estaba bien, aun cuando salía “bien” en sus exámenes de sangre.

Su azúcar estaba alto. Sólo que parecía “bien” porque su metabolismo lo convertía en grasa. Despacio ahora. ¿Sabe por qué Jesucristo nunca se desmayó durante los 40 días que estuvo sin comer? Por el hígado. El hígado produce azúcar. Su hígado produce azúcar. Mi hígado produce

azúcar. Y el hígado de Jesucristo produce azúcar. Todos los hígados, entre otras cosas, producen azúcar cuando no se ingieren alimentos que lo aporten. “Si usted no come, yo me encargo”, dice el hígado. Y cual mecanismo de emergencia, se activa cuando baja el azúcar. ¿O se imagina tener que comer a las tres de la madrugada para evitar el desmayo? No. Eso no ocurre. Gracias a la nueva formación de azúcar o neogluco-génesis del hígado. Porque así se llama. “Neo” por nueva, “gluco” por glucosa, y “génesis” por nacimiento. Que se produce a partir de proteínas. Así es y así seguirá siendo en todos y cada uno de los hígados de este planeta. Sin embargo, existen hígados que son “paleolíticos”. Diseñados para organismos que comerán una o dos lagartijas por día (ambientes desprovistos de agricultura) y que tendrán que salir a cazarlas (con necesidad de mucha actividad física). Esto es, aun sin ayuno: producen azúcar en el hígado como fuente principal de energía. Azúcar o energía que será necesaria, repito, para salir de cacería y comer alimentos que no aportan azúcar. Ahora bien. Imagine qué le pasaría al hígado paleolítico si a la mañana siguiente no sólo no va de cacería, sino que, peor aún, ingiere granos y tubérculos o cualquier alimento que aporte azúcar. La respuesta es… nada. No pasaría nada. No el primer día. Ni el segundo. Ni el tercero. Pero con el tiempo, el azúcar ahora “extra” o “no necesario” proveniente de alimentos (porque el hígado de la persona paleolítica ya lo

produce), se acumularía. Y al acumularse, “empatucaría” al cuerpo. Y “empatucarse” (glicosilarse) los órganos, es el escenario que el cuerpo desea evitar con más fuerza. Así, inteligentemente, antes de que suceda, en el medio intracelular, el cuerpo convierte el azúcar “extra” en grasa que engorda. Porque prefiere, el cuerpo digo, algo malo que algo peor. Prefiere engordar, a empatucarse. Prefiere la grasa en exceso, al azúcar en exceso. Y convierte algo que empatuca, en algo que engorda. Y por eso el hígado graso. O los triglicéridos elevados. O la barriga “de años”. No por grasa. Por azúcar. Proceso que no es más que la representación externa de un proceso inflamatorio intracelular dependiente de la neoglucogénesis. Y con el tiempo, en algunos, este mecanismo fleja. Y aparece la diabetes “de la edad”. Fleja porque “no puede más”. Ya “no puede más”, convertir el azúcar que sobra (no es utilizado), en grasa que engorda. Y sale a la sangre ya no como triglicéridos o barriga, sino como azúcar que empatuca o glicosila. “Diabetes”, dice su médico. “Usted tiene diabetes”.

Sólo para médicos

La neoglucogénesis hepática, inhibida por la insulina, permite a los organismos superiores obtener glucosa a partir de ciertos aminoácidos, del glicerol, del lactato y de algunos intermediarios del ciclo de Krebs, en estados de ayuno y emergencia. Sin embargo, este es el principal mecanismo de producción de energía o glucosa en aquellos con el paleo genoma (metabolismos tipo 3 y 4). Mecanismo reforzado, en ellos, con mayores requerimientos de insulina para su inactividad. Si un hombre paleolítico ya con grasa abdominal ingiere granos, frutas y tubérculos, enfermará. Pero si partimos de la base de que los granos, las frutas y los tubérculos (las carbodrogas) son alimentos sanos para su tipo de metabolismo, concluiremos que tienen un defecto en la supresión de la insulina sobre la producción hepática de glucosa. Aun cuando no hayan, todavía, desarrollado diabetes. Sólo el hígado graso.

Ver:

http://jcem.endojournals.org/content/87/7/3023.short

Como hemos dicho en el capítulo anterior, concluir que el defecto está en el hígado paleolítico y no en los alimentos que ingiere el hombre paleolítico, es concluir que la insolación del blanco es por un defecto en su piel, y no por exponerse al sol siendo blanco. Científicamente, a este "defecto en el hígado" (ventaja paleolítica), le hemos denominado resistencia hepática a la insulina. Resistencia normal y por tanto fisiológica en éstos, cuyo interés es producir glucosa a partir de las proteínas de la dieta durante el ayuno y fuera de éste. La resistencia hepática a la insulina y la neoglucogénesis nocturna aumentada son, en el paciente paleolítico que se "carbodroga", sinónimos. Y la insulina basal elevada es, junto a los triglicéridos elevados, el hígado graso, y la hiperglicemia basal, representaciones paraclínicas del mismo evento que pudieran o no estar presentes. ¿Cómo ocurre? Vale la pena repetirlo, y es que sobre este punto estaremos regresando una y otra vez a lo largo del texto: El hígado produce azúcar (GLUCOGÉNESIS HEPÁTICA) que convierte o almacena como grasa (cuando el paciente se carbodroga) en forma de triglicéridos, barriga e hígado graso, a través de un mecanismo denominado LIPOGÉNESIS HEPÁTICA, que la insulina no logra inactivar (RESISTENCIA HEPÁTICA A LA INSULINA), en aquellos todavía sin diabetes.

Ver:

http://care.diabetesjournals.org/content/32/suppl_2/S164.e

Sin embargo, el hígado no convierte el azúcar en grasa cuando la persona se alimenta paleolíticamente (de animales, vegetales y semillas). En este escenario utiliza el glucógeno hepático como fuente de energía. Y no se estimula la lipogénesis hepática.

No todos con el hígado paleolítico desarrollan la diabetes.

Ya sabe dos cosas. Primera. Cuando su glicemia amanece elevada es porque su hígado lo produce. No porque usted comió azúcar la noche anterior. Hago la aclaratoria porque es frecuente no entender cómo amanece "con azúcar elevado", si la noche anterior tomó sólo consomé. Segunda cosa. Sabe también que sus triglicéridos elevados o su hígado graso o su barriga de años, son el producto final de la glucosa que su hígado produjo diariamente y que también por años convirtió en grasa. Sin embargo, lo que tal vez no sabe, es que no todos con neoglucogénesis nocturna aumentada desarrollan diabetes. En muchos, el hígado nunca deja de convertir el azúcar en grasa. Y en otros, aunque la glicemia se eleva, nunca se empatucan más de lo deseado. ¿De qué depende, entonces, que usted tenga diabetes y su vecino no la tenga, si ambos comparten el mismo proceso inflamatorio intracelular

propio de la neoglucogénesis nocturna aumentada? Del páncreas. De su páncreas. Que ya no pudo compensar.

¿Recuerda la repentina pérdida de peso cuando le diagnosticaron la diabetes?

O tal vez engordó. Pero entre los dos escenarios, el primero es señal inequívoca de fallo pancreático. Señal, digo, de que el páncreas no produjo suficiente insulina para "abrir rápidamente las células al azúcar". Y en este escenario, las células que "no comen o no tragan" pierden peso y se fatigan. Por ello, la pérdida de peso. Y por ello, también, la fatiga. Sin embargo, durante los primeros años, es frecuente contar con "suficiente páncreas" para alimentar "lentamente", como siempre fue ideal, las células del hombre paleolítico. Esto es, con alimentos que se convierten en glucosa a través de su principal mecanismo de producción de energía. La neoglucogénesis hepática. Más aún, en aquel que debutó con diabetes siendo obeso. En este escenario la reserva pancreática es siempre mayor, y el evento es precedido por el clásico y famoso mantra: "Yo estoy bien, apenas tengo el azúcar un poquitico elevado", descuidándose hasta engordar más y hacer una verdadera crisis. En la que pierde varios kilos de músculo en tan solo semanas. Comportándose de modo parecido al muy diferente paciente que no tiene sobrepeso (Grupo 3).

Sólo para médicos

La diabetes está determinada por la incapacidad del páncreas de compensar la resistencia hepática y muscular a la insulina. Con suficiente insulina, no existe diabetes. Pero "suficiente insulina" es una frase que danza con la resistencia a ella. A menor resistencia, más efectiva es la insulina. Y aunque su producción no se puede aumentar (salvo estimular con fármacos), la resistencia siempre se puede disminuir (pérdida de grasa abdominal, alimentos con bajo índice glicémico, actividad física, e hipertrofia muscular). En este sentido, cuando hablamos de pacientes con diabetes tipo 2, es frecuente que caigamos en el error de separarlos en requirientes y no insulinorrequirientes. O peor aún, que todavía no lo son. Paradigma heredado, una vez más, de las "academias" que, como verá, es un obstáculo colosal para revertir la enfermedad. En realidad, para ponerla en perspectiva, 85% de las personas a los 90 años presenta diabetes. Y esto, porque como sabe, la resistencia muscular a la insulina y la neoglucogénesis hepática son eventos fisiológicos que aumentan con los años. En consecuencia, si todos llegáramos a 110, todos seríamos diabéticos. Sin

embargo, estos no son los pacientes que nos ocupan. El abuelo de 80 que amanece con la glicemia en 130, pero tiene la hemoglobina glicosilada normal, no sufrirá de la micropatía diabética. En el otro extremo, el paciente de 45 con barriga particular, que fue y sigue siendo delgado, pero debuta con azúcar alto y pérdida de peso, es el que verdaderamente nos preocupa. Y en un rango intermedio, está el importante y hoy mayoritario grupo que tiene obesidad. De éstos, la mayoría podría revertir o evitar que la enfermedad evolucione. Si se diagnostica a tiempo, se da el tratamiento correcto y el paciente lo ejecuta. Tres factores de los cuales dos, al menos, dependerán siempre de nosotros. Pero para ayudarlos debemos pasar del paradigma antiguo al paradigma actualizado. Paradigma en el que el porcentaje de resistencia hepática a la insulina y el de reserva pancreática con el que debutan los pacientes, los define. En este sentido, existen 2 anormalidades metabólicas completamente diferentes (resistencia hepática a la insulina y fallo pancreático) que se hacen presentes en 3 diferentes escenarios, y que dan lugar a los 3 grupos que debutan con o sin sobrepeso, antes o después de los 60 años de edad, y que conforman la base de este protocolo.

Ver:

http://care.diabetesjournals.org/content/29/5/1130.full

Estos tres grupos de pacientes con diabetes no insulinorrequiriente son, muy a pesar de compartir la misma patología, fisiológicamente muy diferentes entre sí. Y deberán recibir tratamientos también diferentes, referidos en el protocolo de este libro. No son, bajo ningún concepto, ni un mismo paciente, ni 3 estadios diferentes de la misma enfermedad, como las "academias" han dejado sugerir. En el caso de aquel con obesidad e hiperglicemia basal y no postprandial, por citar un ejemplo (Grupo 1 ó 2), el escenario frecuente es patético. Algunos médicos le indican secretagogos por la mañana sin metformina en la noche, "porque el azúcar está elevado por la mañana". Como entenderá, el hígado lo produce durante la madrugada y la metformina lo inhibiría. No así los secretagogos, que aumentan el riesgo a infarto, producen hipoglicemia y bajan el azúcar después que empatucó los órganos. En este escenario, insisto, se estimula la ganancia de peso y en consecuencia la resistencia hepática a la insulina. Y a mayor Resistencia hepática a la insulina, mayor neoglucogénesis. Y a mayor neoglucogénesis, mayor diabetes. Un círculo vicioso que mantiene el proceso inflamatorio intracelular y el aumento de medicinas, con efectos secundarios en el mejor de los casos, y que matan en el peor. Este ejemplo, para no extendernos ahora, deja claro cómo empeora el paciente "siguiendo el tratamiento indicado".

Su
tratamiento
NO SIRVE
porque
BAJA
ELAZÚCAR
PERO
NO
EVITA
QUE
SUBA
Quita los
síntomas
del exceso de

calcio

PERO
NO
EVITA
el exceso de calcio
ATACA
LA
CONSECUENCIA
PERO
NO
EVITA
LA
CAUSA
ACTÚA
FUERA

DE LAS
CÉLULAS
PERO
NO ACTÚA
DENTRO

Y POR ELLO NO CURA LAS CONDICIONES QUE SE PRODUCEN JUSTAMENTE AHÍ

Hígado graso
Fatiga
Pérdida de la memoria
Hipertensión
Mareos
Retención de líquido
Calambres
Dolores
Insomnio
Impotencia
Infartos
ACV
Alzheimer
Calcificación Arterial

Osteoporosis

Y MUCHO MENOS SIRVE PARA FRENAR LA ESCALADA DE MEDICINAS …

Que su
médico
aumentará
AÑO TRAS
AÑO
y que evitan que usted
“vea” las consecuencias

CAPÍTULO 2

Por qué usted puede morir de infarto, aun con el azúcar "bien".

La triada “barriga, hígado graso y triglicéridos elevados”, puede o no acompañarse de la falta de magnesio dentro de las células. Esto, como dijimos, porque existen metabolismos que fueron diseñados para vivir en sitios con aguas y tierras cargadas de magnesio. Y en el proceso de adaptación, para no sobresaturarse, aprendieron a retenerlo y distribuirlo entre los órganos de forma modesta. No haberlo hecho, hubiese significado la no sobrevivencia por exceso del mismo. Hoy, sin embargo, el escenario es el opuesto. Vivimos en urbes desprovistas de este mineral. 85% de la población tiene una dieta deficiente en magnesio. El ciclo hombre-campo-alimento se ha roto. Las evacuaciones ya no caen en tierras que cosechan los vegetales que usted come, y que frecuentemente no come, y que si come matan porque los quema al cocinar. Y el estrés, la ingesta de alcohol, de harinas y dulces, la quimioterapia y el uso de muchos medicamentos, aumentan para colmo los requerimientos de este mineral. Sin embargo, de todas éstas, la consideración más importante es la genética. Individuos con metabolismos que no lo retienen de forma generosa. La ciencia los ha llamado “alteraciones genéticas en la absorción, distribución y eliminación del magnesio”.

Ver:

http://jasn.asnjournals.org/content/14/1/249.abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20081299

http://jasn.asnjournals.org/content/11/10/1937.abstract

http://jcem.endojournals.org/content/87/2/612.full

Sin embargo, en sitios de abundante magnesio, estas "alteraciones" serían, repito, justamente las adaptaciones metabólicas necesarias para la sobrevivencia. Y en sitios de poco magnesio, la principal causa de cualquier enfermedad.

A usted le puede faltar magnesio, aun con su magnesio normal en el examen de sangre

Su examen no dice la verdad. Ya lo hemos dicho. Su examen de sangre es de sangre. De fuera de la célula. Y la deficiencia de magnesio, cuando existe de manera crónica, es en un sitio donde no hay sangre. Dentro de la célula. En este escenario, el cuerpo sacrifica el magnesio intra por el extra celular para mantener el Ph sanguíneo. Y cuando esto sucede, el calcio entra a la célula de manera exagerada "contracturándola" y calcificándola toda. De persistir este escenario, se llegaría a la "paradoja del calcio". Situación en la que los huesos se descalcifican

para alimentar el calcio que debe calcificar los órganos. Y así, lo que está duro se pone blando (los huesos), y lo que está blando se pone duro (los órganos). Produciendo osteoporosis por deficiencia de magnesio (por ello más calcio no evita su osteoporosis). Como lo muestran los siguientes estudios…

Ver:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16274367

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2995550/

http://jcem.endojournals.org/content/91/12/4866

Sin embargo, al inicio, esta paradoja del calcio no es lo que sucede. La falta de magnesio es sólo en algunos sistemas. Eventualmente, la segmentación cede y el organismo es canibalizado, haciendo la deficiencia universal. Así, la falta de magnesio que durante las primeras décadas sólo produce migrañas…

Ver:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9523054

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8486510

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18705538

…eventualmente también producirá cálculos o arenilla en los riñones…

Ver:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6764473

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7418866

…y con el tiempo elevará la tensión arterial…

Ver:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC391954/

http://hyper.ahajournals.org/content/28/3/433.full

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0006291

… y ambos podrán presententarse en el mismo paciente…

Ver:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10419076

http://ndt.oxfordjournals.org/content/16/11/2232.full

… hasta producir infarto…,

Ver:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9736141

…diabetes…

Ver:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8405745
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14693979
http://www.ajcn.org/content/55/6/1161.abstract
http://care.diabetesjournals.org/content/26/4/1147
http://care.diabetesjournals.org/content/15/7/835

…y Alzheimer.

Ver:

http://content.karger.com/produktedb/produkte.asp?doi=110873

http://journals1.scholarsportal.info/details.xqy?uri=/00063223/v37i0005/341_pmdaacsdotat.xml

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2132752

Por ello, y sólo por ello, todas y cada una de estas condiciones se frenan, revierten o curan, con la ingesta de suplementos de magnesio. Sólo magnesio. Y no con medicinas. Y no porque el magnesio sea "la pastilla de moda". Sería ignorante decirlo así. Se frenan, revierten o curan porque su deficiencia las produce. No la deficiencia de medicinas. La deficiencia intracelular de magnesio. Sin embargo, las medicinas muchas veces no se podrán ni deberán evitar por lo avanzado de la condición. Pero no serán nunca sustituto de lo que le falta al organismo. ¿Se imagina consultar al médico por migrañas (falta de magnesio), y que lo "curen o traten" con una medicina, pero no le indiquen el magnesio? Con los años desarrollaría el Alzheimer que su médico tal vez le hubiese podido evitar. Lamentablemente esta situación es muy frecuente. ¿Sabía que el Alzheimer se inicia 20 años antes del primer síntoma?

Sólo para médicos

En una oportunidad, recibí una paciente de 48 años sin menopausia. “Sus taquicardias se quitarán con magnesio”, le dije.

Ver:

http://www.jacn.org/content/26/2/121.full

En la siguiente cita, cuando le pregunté si lo tomaba, me confesó que su cardiólogo se lo había prohibido. “¿Conoce su teléfono?” Lo llamé. “Buen día, es usted el doctor tal…” “Hablando…” “Disculpe, usted no me conoce…, mi nombre es Ludwig Johnson, médico de una paciente de ambos, la señora tal”. “Ah, sí, dígame”. “Entiendo que le prohibió consumir el magnesio y quería conocer el motivo”. “Primero se debe medir su nivel en el examen de sangre”, replicó. “De estar bajo, entonces, y sólo entonces, se puede indicar”. “Eso no es correcto”, dije. “Resultaría normal, porque el problema está dentro de las células. No afuera. Y el examen de sangre es de

afuera". Y aceleré: "Se lo digo porque…" y en segundos vertí mi experiencia ayudando a mis pacientes a revertir sus condiciones con magnesio. "¿Usted sabe quién soy yo?", me interrumpió agresivo. "No". "Pues yo tampoco sé quién es usted. Falta de respeto. Soy un cardiólogo reconocido por la Sociedad Venezolana de Cardiólogos… ¿me oye? Y acabo de presentar una exposición en el último congreso solamente a cardiólogos. Y si usted me quiere decir algo, viene y me lo dice en la cara". Y tiró el teléfono. Me sentí mal. Muy mal. La idea nunca fue la confrontación. Guao. Sólo quería el intercambio. Me apasionaba el tema. Lo sentía urgente. ¡Lo siento urgente! Pero mi pasión no había parecido pasión. Había parecido agresión. Y lo entendí. Lo lamenté.

Pocos días habían pasado del Sexto Congreso de Medicina Anti Envejecimiento en el Gaylord Palms de Orlando, Florida. Acababa de tener el envidiable encuentro, a la salida de su charla, con el mismísimo Dr. Sinatra. Stephen Sinatra, un afamado cardiólogo de Estados Unidos, conocido por sus trabajos en el tema de nutrición cardiovascular. Recuerdo, al terminar su exposición, que los oyentes dejamos al siguiente expositor sin audiencia. Un anillo lo rodeaba con fotos y preguntas. Y yo, que conocía sus trabajos, veía ansioso cómo iba acercándome para verlo de frente. "Doctor Sinatra, is it true that…?" Las preguntas iban y venían. De pronto, su mirada se detuvo en la mía. Era evidente que todos

esperaban mi pregunta. Doctor Sinatra… ¿usted toma magnesio? “¡Magnesio!”, exclamó. “Por supuesto”. Y escuché de sus propios labios cómo toma el doble de lo que yo mismo tomaba para entonces, y el doble de lo que produjo mi altercado telefónico. Días más tarde, recibí un e-mail de aquel doctor. “Gracias a nuestra discusión –decía–, tuve la oportunidad de revisar viejos y nuevos conceptos sobre el magnesio. Y tiene usted razón”. Fue un alivio. Me ofreció disculpas. Yo le ofrecí las mías. Bien vale la pena buscar y leer el siguiente trabajo publicado en el South Medical Journal en 2002. Aquí, al menos, un párrafo que no debe pasar desapercibido en sus últimas 4 líneas.

Ver:

http://www.medscape.com/viewarticle/423568_3

Por un lado, queda claro que los niveles de Magnesio en la sangre no son representativos de lo que ocurre en el cuerpo. Pero por otro lado, y tan importante como este punto, es que 40% de nuestros pacientes tienen distorsiones genéticas (prefiero denominarlas condiciones genéticas) que condicionan (valga la redundancia) la absorción, distribución, retención y eliminación del Magnesio, en un mundo sin él.

Ver:

http://www.medscape.org/viewarticle/568950_5

El día que los médicos enseñemos esto en las escuelas de medicina, bajaremos la tasa de todas las enfermedades en más de un 70%, y, con seguridad, el consumo de medicinas en más del 90. No quiero pensar que sea este factor la causa por la cual lo ignoramos.

Los paradigmas "tengo diabetes, no tengo diabetes" y "tengo el colesterol elevado, tengo el colesterol normal", han hecho mucho daño

Daño, inclusive, a los propios médicos, que no dejan de sorprenderse cuando sus familiares "sanos y de colesterol normal" caen muertos por infarto. Se ha hecho creencia, por alguna razón, que sin diabetes, y con la tensión y el colesterol normal, la vida no corre peligro. Sin embargo, nada está más lejos de la verdad. La mitad de los infartos ocurre en personas con el colesterol normal. Más de la mitad de los hipertensos que se infartan lo hacen con la tensión controlada. Y existe igual número de pacientes infartados con diabetes que de infartados sin diabetes. ¿Por qué? Porque la tensión elevada, la glicemia elevada y los triglicéridos elevados son, en aquellos con neoglucogénesis nocturna aumentada, los síntomas de la

enfermedad. Pero no son la enfermedad.

Ver:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9579251

Como hemos dicho en el capítulo anterior, el verdadero riesgo a infarto danza entre la falta crónica de magnesio y la neoglucogénesis aumentada. Mucha falta de magnesio y poca neoglucogénesis aumentada, es igual a muerte. Y mucha neoglucogénesis aumentada y poca falta de magnesio, también lo es. Esta es la razón, por cierto, por la cual aquellos conocidos con las arterias del corazón enfermas (enfermedad arterial coronaria), mejoran al administrarles suplementos de magnesio. No porque el magnesio sea bueno o milagroso. Sino porque su falta produce la enfermedad.

Ver:

http://circ.ahajournals.org/content/102/19/2353.long

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15167956

Y es, además, la razón por la cual aquellos que más se infartan son quienes más sufrieron síntomas de falta de

magnesio en la juventud. Como migrañas o dolores de cabeza, por citar, entre tantos, un solo ejemplo. Si le gusta el tema, y quiere saber más al respecto, no deje de buscar el siguiente estudio:

Ver:

http://www.neurology.org/content/74/8/628.short

¿Qué es peor, entonces, tener barriga, tensión alta y triglicéridos elevados, o tener diabetes controlada? La mayoría pensaría que el peor escenario lo tiene el diabético. Pero el peor escenario lo tiene, quien de los dos está sin magnesio. La hemoglobina glicosilada en rango le garantiza al paciente con diabetes que no se quede ciego, no pierda los riñones y no le amputen los pies con el tiempo. Pero la ausencia del magnesio le asegura el accidente cardiovascular y el infarto a los dos.

Ver:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12972103

Sólo para médicos

Es frecuente recibir pacientes con tratamientos “para el azúcar”, pero no “para” la enfermedad. Como dijimos, evitar la micropatía diabética (lHbA1c en rango), pero sin revertir el sindrome metabólico, es mantener el riesgo cardiovascular intacto.

Ver:

http://www.medscape.com/viewarticle/578827

En el síndrome metabólico del paciente con o sin diabetes, ni la hipertrigliciridemia debe ser sólo medicada con fibratos, ni la hipertensión sólo con antihipertensivos, ni la hiperglicemia sólo con hipoglicemiantes. Hacer esto, repito, porque hay que repetirlo, es ignorar que el “afuera” es consecuencia del “adentro”. Porque si el tratamiento quita la consecuencia, pero no quita la causa, la inflamación, la oxidación y la calcificación intracelular quedarán intactos. Responsables estos, culpables digo, del infarto “aun con la glicemia en

rango". O deberíamos decir, "aun con el afuera en rango". Porque el tratamiento siempre "dejó el adentro mal". Siendo "el afuera" la sangre, y "el adentro" el medio Intracelular. La neoglucogénesis nocturna aumentada y la hipomagnesemia intracelular son, en resumen, los dos eventos que comparten los pacientes diabéticos con aquellos con síndrome metabólico. Y son además, los dos fenómenos intracelulares que deben ser abortados para evitar la inflamación, la oxidación y la calcificación intracelular que ambos comparten (y la retroalimentación positiva de la falla pancreática exclusiva de los primeros) con un estilo de vida paleolítico. En este sentido, los pacientes con diabetes y aquellos sólo con síndrome metabólico, no son dos pacientes desde el punto de vista cardiovascular. Muy al contrario, son el mismo paciente, que aunque con pronóstico diferente por la micropatía de los primeros, deben ser "medicados" con la dieta paleolítica antes que con cualquier otro medicamento.

Ver:

http://www.springerlink.com/content/h7628r66r0552222/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19604407

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19209185

http://www.mayoclinicproceedings.com/content/79/1/101.

Ya para avanzar, debemos aclarar que no todos con el proceso inflamatorio intracelular hacen la hipertrigliciridemia. Como tampoco el hígado graso. La formación hepática de grasa a partir del azúcar, que tiene salida en estos dos bandos, frecuentemente lo hace en uno primero, para después hacerlo en el otro. Interrumpir este proceso es lo único capaz de mejorar la sensibilización hepática a la insulina. Órgano que mientras más inflamado esté, más resistente será a inhibir la producción de glucosa por ésta, cuando fisiológicamente convenga inhibirla. En esencia, los que me han seguido hasta aquí entenderán que la neoglucogénesis nocturna aumentada es sinónimo y consecuencia de la resistencia hepática a la insulina. Aumentada fisiológicamente, valga la redundancia, en aquellos diseñados para vivir en regiones paleolíticas (mecanismo de preservación de la especie) donde no existen las carbodrogas. Por ello, las carbodrogas son el verdadero origen del problema (granos, harinas, frutas, dulces y tubérculos). Y retirarlos de la dieta, la verdadera cura de la hipertrigliciridemia y el hígado graso. La verdadera cura no son más medicinas.

Ver:

http://www.medscape.com/viewarticle/732212

CAPÍTULO 3

"Yo te enfermo,
yo te curo"

Las Academias "serias".

Si su tratamiento sigue los lineamientos de la Academia Americana de Endocrinólogos, es probable que no revierta la enfermedad. Y la razón es sencilla. Las harinas, los granos y las frutas estimulan la resistencia hepática a la insulina y elevan la glicemia. Las grasas no. Y la pauta de la academia es ingerir dietas 60% de harinas, granos y frutas, y limitar las grasas al 15%. Tal recomendación es al diabético, como sugerirle al albino los días bajo el sol. Más absurda, contraproducente e ignorante, imposible. Si el problema es el azúcar alto y la solución evitar que suba, ¿por qué indicar los alimentos que lo elevan? La respuesta, en el inconsciente de los médicos, es que los granos, las harinas y las frutas son la fuente de la energía. De no ingerirlos, dicen, el cuerpo se comería los músculos. Concepto que, lamenta-blemente, nos ha costado muchos riñones, muchos ojos, muchos cerebros, muchos corazones, y muchas vidas en general.

Ver:

http://www.nutritionandmetabolism.com/content/2/1/35

Como explicamos en el primer capítulo, los seres humanos producimos el azúcar en el hígado, a partir de la

carne, del pollo, del pescado, de los huevos y de todas las proteínas en general (neoglucogénesis hepática). Pero en aquellos con el metabolismo paleolítico, con diabetes o sin ella, la neoglucogénesis es mayor todavía. Cuando los nutricionistas nos advierten que no podemos retirar los glúcidos o los azúcares de la gente, tienen razón. No podemos. Tendríamos que retirarles el hígado. Sobre todo a quienes son paleolíticos. Porque en ellos, las proteínas son la fuente primordial de energía.

Los tubérculos, las harinas y las frutas son la fuente de la fatiga

En aquellos con el paleo genoma, las carbodrogas producen un "bajón" a las dos horas de ingeridos. ¿Por qué? Porque no son alimentos paleolíticos. De hecho, si una persona paleolítica no desayuna, a las dos horas no tendrá hambre. Por el contrario, si desayuna un cereal o una fruta, a las dos horas tendrá "ansiedad por algo" o "un hueco en el estómago". Es el clásico "bajón" que nunca ocurre con proteínas. Y esto, repito, en quienes tienen diabetes y en todos con este metabolismo (los hijos de aquellos). Cuando están gordos también son víctimas del clásico mantra: "Si hacen esas dietas locas sin carbohidratos, perderán peso de músculo y no de grasa. Porque sus cuerpos tomarán el músculo para convertirlo en la energía". ERROR. Sus cuerpos siempre tomarán las proteínas de la dieta (nunca del músculo) para

convertirlas en la energía. Siempre. Con dietas “locas” o sin dietas “locas”. Si es paleolítico y come pollo, lo convertirá en azúcar (porque el hígado está genéticamente codificado para convertir las lagartijas en la energía. O los pollos). Porque en el mundo paleolítico, no hay arroz que aporte “la energía del nutricionista”. Y por ello, si ingiere pollo con arroz, también convertirá el pollo en la energía. En ambos casos, el hígado hace lo mismo. Con arroz o sin arroz, convierte el pollo en azúcar. Pero cuando ingiere arroz, su cuerpo retiene líquido, su hígado lo convierte en grasa y le aparece “el caucho o la barriga”. Y con el tiempo, le pondrá el hígado graso, le alterará la menstruación, le sacará verrugas en el cuello (acantosis nígricans) y le subirá la tensión arterial. Y si tiene diabetes, la glicemia inclusive. Excepción hecha del atleta que “lo quema” con ejercicio. Que de no hacer mucho, igualmente lo almacena. Esto, repito, en aquellos paleolíticos. ¿Existió la diabetes Tipo 2 en la era de piedra? No. ¿Por qué? Porque no había agricultura. Las harinas, los granos y las frutas elevan la glicemia que el hígado abastece. En el paleolítico, las proteínas son la fuente de la energía y las carbodrogas de la fatiga.

Su último día sin diabetes.

“El hígado ya no convirtió el azúcar en grasa”. No más lipogénesis hepática a partir de neoglucogénesis hepática. Y el azúcar, por vez primera, “salió” como azúcar y no

como triglicéridos o barriga. ¡Diabetes! lo diagnosticaron aquel día. Y es que entender cómo se entra, es entender cómo se sale. No ingerir los mismos alimentos que estropearon “los oídos” del hígado al “llenarlo de grasa”, y que “impidieron escuche” a la mucha o poca insulina cuando “le pide” que suspenda su producción de azúcar (resistencia hepática a la insulina). La diabetes tipo 2 no es una enfermedad del páncreas como se nos ha hecho ver. Es una enfermedad del hígado paleolítico que ha entrado en contacto con alimentos anti paleolíticos, y que termina “llevándose” al páncreas, también paleolítico, según su reserva. La diabetes 2 no es entonces una enfermedad. Es una consecuencia. Sin embargo, la Academia Americana de Endocrinólogos y la Asociación Americana de Diabetes sugieren enfermar con carbodrogas y medicar con medicinas. “Yo te enfermo el cuerpo, pero te curo la glicemia”. No me gusta su lema. Tampoco al doctor Krumholz, mencionémoslo ahora si, después de haber mostrado el párrafo donde explica cómo los estudios ACCORD y ADVANCE nos obligan a revisar los mecanismos hasta ahora utilizados para controlar la glicemia. A mayor cantidad de medicinas, nos dice, más riesgo de muerte a pesar del mejor control. Y el Dr. Steven Nissen, quien en un segundo párrafo comenta “Las estrategias que estamos utilizando para bajar la glicemia, no están disminuyendo el riesgo cardiovascular”. Estoy de acuerdo. Ingerir diariamente los alimentos que elevan

patológicamente la glicemia (carbodrogas que aumentan la excursión glicémica o GAME), utilizar como base del tratamiento medicinas que hoy sabemos aumentan la mortalidad (y no en momentos puntuales como es ideal) tales como las sulfonilureas, y no reconocer la deficiencia del Magnesio cuando existe, nos ha costado caro. Muy caro. Por favor, no más.

Ver:

http://www.theheart.org/article/932799.do

"Son esas mismas dietas de moda, altas en proteínas, que lo único que hacen es deshidratar al paciente".

Otra anécdota. Estoy en un congreso. Gente inteligente. Amigos inclusive. De diabetes. Invitan al estrado al siguiente panelista. Es una mujer pasada de peso, ya en sus avanzados 50. Es la jefe del departamento de nutrición tal y tal. "Muy buenos días". En eso, hace una afirmación profundamente ignorante. "Las grasas engordan porque aumentan la resistencia a la insulina y aportan muchas calorías". Dios mío, pensé. Todo lo contrario. La gente con diabetes ni engorda por ingerir muchas calorías, ni adelgaza por ingerir pocas. Engorda porque ingiere alimentos que requieren mucha insulina y adelgaza porque ingiere alimentos que requieren poca. Y las grasas no

requieren ninguna. Más aún, las grasas disminuyen la resistencia a la insulina. No la aumentan.

Ver:

http://www.annals.org/content/140/10/769.full

La doctora continuó, "hicimos un estudio en el que sometimos a pacientes obesos con diabetes a dietas bajas en grasa. Pero no perdieron peso y no mejoraron su resistencia a la insulina. No sabemos por qué". La panelista terminaba su presentación y yo pensaba en los 32.000 hijos de los 16.000 pacientes que serían vistos, en los próximos meses, por los 400 médicos que estaban ahí. Que lástima. Las grasas, como verá a continuación, son buenas, controlan la glicemia, sacian, y adelgazan. Todas. Inclusive las que usted llama malas. Todas. Con o sin colesterol, saturadas o no, las grasas aumentan el HDL, lubrican la piel, mantienen saludable el intestino (órgano endocrino), no elevan el colesterol malo, y no engordan.

Ver:

http://www.ajcn.org/content/80/5/1102.full

http://jama.ama-assn.org/content/295/6/655.abstract

http://www.jci.org/articles/view/116375

http://www.ajcn.org/content/early/2010/01/13/ajcn.2009.2

A excepción de la grasa inventada, creada o manufacturada por el hombre –la hidrogenada–, todas las grasas son buenas. Las carbodrogas, al contrario, son malas. Porque engordan y tapan las arterias. Los tubérculos, los granos y las frutas, al entrar en contacto con la insulina del hombre paleo (paleolítico), se convierten en la grasa que tapará sus arterias, formará sus triglicéridos y sacará su barriga. Esta es la razón, dicho sea de paso, por la que no alimentamos los cerdos con grasa. Sería económico, porque el carnicero la desecha. Pero el criador de cerdos prefiere pagar grandes sumas de dinero por granos, para así poder engordar sus animales. O a sus gansos. Que tampoco les damos dietas altas en grasa para producirles el hígado graso. Porque las grasas, querida doctora panelista, no producen el hígado graso (otra grave equivocación hecha en público frente a los hipnotizados 400 médicos que estaban presentes). A los gansos los alimentamos con maíz (grano, cereal, tortilla, bollito, arepa) para la producción del paté. Porque el maíz pone el hígado graso. Y bien graso. A continuación, un estudio publicado en el Journal of Gastroenterology que lo deja claro. Dietas altas en carbodrogas y bajas en grasas. Las culpables del hígado graso. ¿Y el culpable de que la panelista de aquel congreso, jefe del servicio de nutrición tal y tal, todavía no lo sepa… quién es?

Ver:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17032189

Por ello, al retirar las carbodrogas de la dieta, si "sufre de triglicéridos elevados", estos se normalizan. "No entiendo por qué tengo los triglicéridos elevados porque en mi casa comemos sin grasa", dice usted. Le pasa como a nuestra panelista jefe del departamento tal y tal. Que no entiende por qué eliminando las grasas sus pacientes diabéticos no disminuyen la resistencia a la insulina. Y no lo entiende, porque las instituciones "serias" a las que sigue, le han dejado ver que eso es lo que debería ocurrir (aunque la medicina basada en evidencia muestre lo contrario). Y esta es también la razón, por la que el Centro de Diabetes, Endocrinología y Metabolismo del Hospital de Oxford hace anuncios como éste:

Ver:

http://www.theheart.org/article/1042243.do

…en el que es evidente que el resultado les sorprende. Note usted que han dividido a los grupos en "Comida saludable" por un lado, que contiene carbodrogas, y en "Dietas bajas en carbohidratos" por el otro. Al menos, en

esta institución, han tenido la precaución de no llamarlas "Dietas locas o de moda". Luego, un endocrinólogo hizo la siguiente pregunta: "Qué sabe usted de la dieta South Beach. La recomienda? Muchos de mis pacientes han logrado perder peso con ella". A lo que nuestra panelista respondió: "Ah, sí, claro…, son esas mismas dietas de moda que lo único que hacen es deshidratar al paciente, haciéndole perder peso de agua". Detengámonos un momento. La dieta South Beach, para aquellos que no la conocen, es una dieta promocionada por un cardiólogo norteamericano, sin carbodrogas. Igual que la dieta Dukans. O Atkins. O la dieta The Joslin Diabetic Diet (de los años 1920) o cualquiera con o sin grasa, pero sin carbodrogas. Bien. Nuestra panelista continuó: "No existe ninguna asociación seria que avale ese tipo de dietas". Un momento. En primer lugar, las dietas sin carbodrogas no hacen que el paciente se deshidrate o pierda peso de líquido. Al contrario. Son las carbodrogas que retienen líquido, lo que es diferente. Si usted elimina las carbodrogas de la dieta, su cuerpo no retendrá líquido. No lucirá hinchado, con el anillo del dedo apretado y las piernas a punto de estallar. Pero jamás se deshidratará. Porque comer sin carbodrogas lo mantiene hidratado. Sólo que sin retener líquido, repito. Razón por la que las carbodrogas elevan la tensión arterial. Y razón también por la que las "dietas locas o de moda" controlan al hipertenso mejor inclusive, que las mismas medicinas.

Lea el encabezado de este próximo estudio (BP: Blood Preassure).

Ver:

http://www.theheart.org/article/1042243.do

Para continuar con la afirmación de aquella panelista, la frase "dietas de moda" es la forma como algunos evitan discutir (porque preferirían morir antes de aceptar que tienen años equivocados), la dieta de vida y no de muerte. ¿De moda? Las modas pasan. Pero esta "moda" lleva desde la edad de piedra sin ser atacada. Hasta 1955. Cuando "los que saben" descubrieron grasa en las arterias de aquellos con infartos. Por favor, lea la séptima línea del Bakcground del siguiente estudio. Deja claro como en 1920, antes de contar con la insulina como tratamiento para la diabetes, el arma principal en la terapéutica eran las dietas 75% a base de grasas.

Ver:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16318637

Y ya para terminar con la jefa del servicio tal y tal, debo referirme a su otra frase: "No existe ninguna institución

seria que avale ese tipo de dietas". Tal vez sea cierto. Que no existan instituciones serias que la avalen. Pero estudios serios que la avalen, a "este tipo de dietas", sobran. Y sería razón suficiente para que aquellos con metabolismo paleolítico, con o sin diabetes, prefieran las "no serias" entonces. Si las "no serias" son las que avalan evitar la diabetes, requerir menor cantidad de medicinas y nos permiten sonreír. Contrario a las "serias", años atrás de la evidencia científica, que aumentan el requerimiento de medicinas, que nos confunden en el mejor de los casos, y nos hacen llorar en el peor.

Ver:

http://cardiology.jwatch.org/cgi/content/full/2004/709/1

Un segundo panelista, esta vez argentino y de excelente poder comunicacional, expuso cómo los análogos del GLP 1 (medicamento para tratar la diabetes que imita una sustancia que quita el hambre, normaliza la glicemia y es producida por el propio organismo en el intestino) adelgazan y controlan la glicemia en quienes tienen diabetes y obesidad. Luego afirmó: "Las grasas, al ser ingeridas, estimulan la liberación del GLP 1 por parte de las células del intestino". ¿Qué dirán ahora?, pensé. Un médico dice que las grasas engordan y producen resistencia a la insulina. Y otro, acto seguido, dice lo

contrario. Nadie comentó nada. Increíble. Hasta dónde nos han hipnotizado. Dios mío. Hasta dónde.

Ver:

http://cardiology.jwatch.org/cgi/content/full/2004/709/1

Ingerir grasas saturadas estimula la liberación de una sustancia anti diabética en el organismo (GLP-1). Sin embargo, los médicos preferimos indicar medicinas que hacen exactamente lo mismo y limitar la ingesta de las grasas. Por Dios, una vez más, hasta dónde nos han hipnotizado.

¿Conclusión? La ciencia dice que las "dietas locas" son las correctas. Pero algunos médicos dicen que no lo son. ¿Por qué? Porque las academias "serias" dicen que no lo son. De acuerdo. ¿Pero por qué las academias dicen que no lo son, cuando la evidencia científica afirma lo contrario?

Yancy WS Jr et al. A low-carbohydrate, Ketogenic diet versus a low-fat diet to treat obesity and hyperlipidemia: A randomized, controlled trial. Ann Intern Med 2004 May 18; 140:7 69-77

Stem L et al. The effects low-carbohydrate versus

conventional weight loss diets in severely obese adults: One-years fallow-up of a randomized trial. Ann Intern Med 2004 May 18; 140:778-85.

Willett WC. Reduced-carbohydrate diets: No roll in weight management? Ann Intern Med 2004 May 18; 14 0:83 6-7.

Ser paleolítico y comer carbodrogas y proteinas, es comer azúcar dos veces. Y en este escenario, alguien se alegra. La industria farmacéutica. Que nos manda ida y vuelta todo pago a los médicos, con familia incluida, a los congresos. Mientras escuchamos las propiedades de la nueva droga que saldrá al mercado para bajar la glicemia que las carbodrogas habrán de elevar, nuestros hijos se divierten en la piscina de un buen resort. Qué ironía. En ellos, jamás escuché una charla sobre el magnesio. ¿Será que no conviene? El magnesio no se puede patentar. Decir: “No coma harinas, ni dulces” no produce dinero. Y es que, en el mundo desarrollado, a los 60 años, uno de tres ya tiene diabetes. ¿Qué siente la industria de “este mercado”?

Cuando la glicemia está elevada, el hígado se come los músculos. Cuando la glicemia está controlada, el hígado se come la comida.

Cuando debutó con diabetes (Grupo 3 o Genotipo 3), su

hígado se comió los músculos. Esto, porque al no “entrar” el azúcar en las células, el hígado “siente” que usted no ingiere alimento. Señal que activa la neoglucogénesis hepática a partir de los músculos. Y ya no de la carne, del pollo, o de las proteínas de la dieta. Porque aunque las coma, “no entran en las células”. En este estado (crisis de azúcar alta), las células no cuentan con el tiempo necesario para absorber los nutrientes. ¿Segunda conclusión? Con la glicemia elevada, el hígado se come los músculos. Con la glicemia en rango, el hígado los preserva. Con glicemia elevada entonces, la neoglucogénesis es a partir de los músculos. Y controlada, a partir de las proteínas de la dieta.

Sólo para médicos

Es frecuente. El paciente que nos consulta porque repentinamente ha perdido 10 kilos, se realiza exámenes de sangre y descubre su glicemia en 300 mg/dl, por citar un ejemplo. Si le preguntamos qué come, nos dirá que "bien sano" porque ha estado preocupado. "Cereal con leche descremada, plátano al horno, arroz blanco, pollo a la plancha…, sin grasa. Pero igual me siento muy fatigado y he perdido mucho peso", nos dirá. Tan pronto usted le retira el cereal, el plátano y el arroz de la dieta, y le indica Metformina, verá frenar la pérdida de peso y recuperarlo inclusive. Sólo con vegetales y proteínas o la "dieta loca sin carbohidratos". ¿Cómo es esto posible? ¿Un paciente "engorda" (recupera su masa muscular) comiendo "la dieta loca" que adelgaza a los obesos? ¿Un paciente que recupera su masa muscular comiendo la dieta que los nutricionistas dicen que se come los músculos? ¿Y además tomando Metformina? Como bien sabe usted, la Metformina promueve la pérdida de peso en el obeso con resistencia a la insulina. ¿Que la Metformina promueve la ganancia de peso (no es peso, es músculo) en el paciente con azúcar alto, aun sin ingerir carbohidratos? A los

médicos que atacan “estas dietas”, esto debería llamarles la atención. A los médicos que conocen la fisiología, no. En un estado de hiperglicemia, si usted suspende la ingesta de carbodrogas, las células contarán con más tiempo para absorber y “barrer el exceso” de glicemia (proveniente del hígado) ya no empeorada por carbodrogas. Y al absorber la glucosa, el organismo recibe los nutrientes para fabricar los músculos antes “comidos” por la glicemia elevada (el peso perdido). ¿Es esto acaso una paradoja? ¿El que un tipo de dieta (sin carbohidratos) adelgace a unos (aquellos con obesidad y sobrepeso), y engorde a otros (aquellos que venían con glicemia elevada)? Por Dios, no. No es una paradoja. Es el mismo evento fisiológico en dos estados distintos. La mayoría de quienes critican “las dietas locas” jamás las han indicado a sus pacientes. Y en consecuencia, jamás han visto, por citar otro ejemplo, a los triglicéridos corregir desde 700 mg/dl en menos de 2 meses sin ninguna medicina. Y jamás han escuchado la sorpresa de los pacientes al descubrir que el subibaja triglicéridos altos/toma medicinas, sácate exámenes/triglicéridos normales, suspende medicinas/repite exámenes, triglicéridos otra vez elevados/retoma medicinas, puede ser dominado por ellos. Sin embargo, estos son los médicos, sin experiencia repito, que se dan el tupé de dictar cátedra sobre “estas dietas” (que coloco entre comillas porque no son dietas, sino la forma natural de

vivir y no de morir de aquel con el paleo genoma). Cuando estoy en consulta, siempre escucho con tristeza al paciente polimedicado que no ha debido estarlo. Poliefectosecundariado, polienfermado, polipreocupado, policonfundido y poligastando dinero. Esta sensación de tristeza, por cierto, la sentí en un congreso en el que un médico a quien respeto, mostró en una lámina cómo somos una región, comparada con China y otros países, que iniciamos la insulina mucho después que el promedio. En China la inician a los 6 años, y sin embargo, dijo, en Venezuela lo hacemos a los 12 años del diagnóstico de la diabetes tipo 2. ¿Por qué tenemos que esperar tanto?, le preguntó a la audiencia. Cuando un medicamento es indicado, a los 3 días ya sabemos lo que hizo y seguirá haciendo. Si la glicemia sigue elevada, ¿qué es lo que estamos esperando?, insistía con la pregunta. Comentarios ciertos, pero falsos si retiramos las carbodrogas del paciente. Muchos medicamentos, como ha leído en la evidencia, son eliminados o disminuidos en el diabético que ya no se carbodroga. La pérdida de grasa abdominal junto al aumento de la masa muscular, que se produce eliminando las carbodrogas de la dieta, son las dos medicinas más importantes con las que cuenta el diabético para controlarse, y el médico para controlarlo. No la insulina, como ese mismo doctor mostró en otra lámina. Quien tenga esta información sabrá explicar por qué sólo 9% de aquellos con insulina se encuentran controlados.

Esto, en contraste con el 12% de quienes sólo reciben medicación por vía oral. ¿No es esto una paradoja? Preguntaba otro panelista que planteaba la pregunta. ¿El que la insulina sea el más efectivo de los hipoglicemiantes, y sin embargo, quienes la usan, están peor controlados que quienes no? Algo para pensar, concluía. Si pierde grasa abdominal y aumenta la masa muscular, repito, las medicinas que nuestro primer panelista decía, en 3 días ya muestran hasta dónde controlan la glicemia, se hacen más potentes. En este sentido, vale la espera. Indicar insulina con carbodrogas en estos escenarios siempre aumenta la excursión glicémica en el mejor de los casos, y engorda y produce hipoglicemia, en el peor. Sin embargo, como lo verá en nuestro protocolo, cuando la insulina está indicada, no deberá postergarse. Escenario frecuente en el Grupo o Genotipo 3, también de este protocolo: aquellos con diabetes tipo 2 antes de los 50, pero delgados y con barriga. Genotípicamente parecidos a la raza china con diabetes, quienes también cuentan con el índice de masa corporal entre 24 y 27. Es decir, que no son obesos. Sin embargo, también genotípicamente contrarios a nuestros más frecuentes pacientes diabéticos, aquellos del Grupo 1: Los obesos. Con diabetes antes de los 50, pero obesos. En estos, indicar la insulina de manera crónica es un grave error. Compararlos con los chinos es un error. Sin embargo, el médico que no retira las carbodrogas de la

dieta de este paciente obeso, tendrá ocasiones en las que no sabrá qué otra cosa hacer, más que cometer el error. La insulina no es el final común de los pacientes con diabetes 2. No lo es y no tiene porque serlo. Utilizar la insulina en el tratamiento de la diabetes 2 no ha probado, ni preservar las células beta, ni reducir la morbimortalidad. La insulina exógena no se comporta como la endógena. Cuando proviene del páncreas, el hígado la recibe antes que cualquier tejido del organismo, produciendo el esperado cese de la glucogénesis y neoglucogénesis.

Ver:

http://care.diabetesjournals.org/content/34/Supplement_2/S

Pero exógena se requieren niveles de exagerada hiperinsulinemia para que esto suceda. De esta manera, la insulina se reparte primero entre los tejidos periféricos antes de llegar al hígado, el órgano que más le necesita. Esta diferencia, entenderá usted amigo colega, entre insulina endógena e insulina exógena, es crucial para entender el correcto manejo del paciente con diabetes 2. En conclusión, resultados es el nombre del juego. Un paciente con la glicemia ya normalizada, sin fatiga, y ya recuperando su masa muscular, con “la dieta loca”, debería seguir con “la dieta loca”. Porque el éxito no es refutable. Si usted toma agua y se le quita, lo que tenía era

la “enfermedad” de la “sed”. Y si usted no ingiere carbodrogas y se normalizan sus triglicéridos y su glicemia, lo que tenía era la “enfermedad” de las “carbodrogas”. Para el médico que lo ha experimentado, estas líneas no serán necesarias. Para el que no, deberán ser fuente de alegría. Pues habrá encontrado un medicamento mucho más poderoso que todos los medicamentos juntos mostrados en los congresos. La comida paleolítica.

Osterdahl M, Kocturk T, Koochek A, and Wandell PE: Effects of a short-term intervention with A Ppaleolithic diet in healthy volunteers. Eur J Clin Nutr 62(5) (2008): 682–685.

Lindeberg S, Jonsson T, Granfeldt Y, Borgstrand E, Soffman J, Sjostrom K, and Ahren B. A Palaeolithic diet improves glucose tolerance more than a Mediterranean-like diet in individuals with ischaemic heart disease. Diabetologia 50(9) (2007): 1795–1807.

Jönsson T, Granfeldt Y, Erlanson-Albertsson C, Ahren B, and Lindeberg S. A Paleolithic

diet is more satiating per calorie than a Mediterranean-like diet in individuals with ischemic heart disease. Nutr Metab (Lond) 7(1) (November 30, 2010): 85.

Frassetto LA, Schloetter M, Mietus-Synder M, Morris RC, Jr., and Sebastian A. Metabolic and physiologic improvements from consuming a Ppaleolithic, hunter-gatherer type diet. Eur J Clin Nutr (2009).

Dos comentarios. El primero, referirme a la frecuente afirmación de que las dietas sin carbodrogas dañan o dañarán los riñones. Ante esto, debo decir que comer sin carbodrogas no es alto ni bajo en proteínas. Es sin carbodrogas. En este sentido, la dieta ideal para un paciente renal estará conformada por 50% carbohidratos (vegetales y semillas), 35% grasas (la mitad de ellas saturadas), y 10 a 15% proteínas (no superando el límite de 0,8 g por kilo de peso, recomendado para estos casos). Sin embargo, si el paciente diabético con toque renal hubiese vivido sin ingerir carbodrogas, nunca hubiese llegado a ser un paciente renal. Por otro lado, las carbodrogas sí que dañarán los riñones. Nadie discutirá el efecto que tiene la hipertensión sobre el funcionamiento renal. Como vimos en uno de los estudios, retirar las carbodrogas normaliza al hipertenso. ¿Por qué? Porque incluir carbodrogas en la dieta del hombre paleolítico, siempre elevará la tensión arterial. Como dije, tal comentario sobra en el médico que practica estos principios. Bien. Final del primer comentario. Segundo comentario. Existen quienes dicen que las dietas sin carbodrogas y altas en proteínas (y espero que ya sepa qué son las carbodrogas) producen osteoporosis porque aumentan la excreción de calcio por la orina. Nada está más lejos de la verdad (lo que si produce osteoporosis es

dejar al 85% de nuestros pacientes sin suplementos de magnesio, en un mundo sin magnesio).

Ver:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21248199

La acidez por ingesta de proteínas es compensada por la inexistente acidez que produce la hiperinsulinemia por carbodrogas. Más aun, por la abundante ingesta de vegetales que siempre sustituyen el espacio de estas (y no diga usted si se suplementa con magnesio. Un mineral que aporta alcalinidad al organismo). En fin, una forma de alimentación que es tan sana, que inclusive evita y hasta disminuye la progresión del cáncer. ¿Qué más se le puede pedir a la comida?

Ver:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21673053

¿Cómo prefiere entonces, dígame usted, amigo lector, mantener su glicemia controlada?

¿Con medicinas que aumentan el riesgo a tener infarto y accidentes cardiovasculares (ACCORD ADVANCE) o evitando las carbodrogas de la dieta? La respuesta, a estas

alturas, debería ser evidente para cualquier lector.

Si todo esto es verdad, ¿por qué su médico dice lo contrario?

Otra anécdota. En una oportunidad, llegó a mi consulta una señora de 70 años de edad con su hija de 40. Era su segunda visita, y tocaba reevaluar los cambios del tratamiento que yo le había indicado. La señora, a quien llamaré Matilde, era conocida por su endocrinólogo desde hacía más de 10 años con los diagnósticos de Diabetes No Insulinorrequiriente, Enfermedad Arterial Coronaria, Infarto al Miocardio y Obesidad. Candidata, Matilde, a una operación de corazón abierto en las próximas semanas, Me decía: "Siento gran ilusión de ver que con este tratamiento, finalmente, se me normalizó la glicemia. Me siento más enérgica, y además tengo cuatro kilos y medio menos de grasa abdominal. Mire, el pantalón que adoro ya me entra". De pronto, su hija interrumpió. "Ayer fuimos a su endocrino. Preguntó por qué usted le había suspendido el Amaryl (Glimepiride) de 4mg del desayuno. Y además, dijo que debía agregar una taza de arroz al almuerzo. Lo necesita para que la pérdida de peso no sea de músculo, sino de grasa". Wouu, pensé. ¿Era este el mismo doctor que durante más de 10 años fue incapaz de regularle la glicemia a la señora, incapaz de ayudarla a perder grasa abdominal, e incapaz de evitar un medicamento que le aumentaba el riesgo de tener un

infarto? (El Amaryl es una Sulfonilurea, y las Sulfonilureas aumentan el riesgo de tener un infarto. Y esta paciente tenía aún mayor riesgo pues inclusive ya había tenido un infarto).

- Simpson SH, Majumdar SR, Tsuyuki RT, et al. Dose-response relation between sulfonylurea drugs and mortality in type 2 diabetes mellitus: a population-based cohort study. CMAJ 2006; 174:169-174.
- Meinert CL, Knatterud GL, Prout TE, et al. A study of the effects of hypoglycemic agents on vascular complications in patients with adult-onset diabetes. II. Mortality results.Diabetes 1970; 19 (Suppl):789-830.
- UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood-glucose control with sulfonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes. Lancet 1998; 352; 837-853.
- Johnson JA, Majumdar SR, Simpson SH, et al. Reduced cardiovascular morbidity and mortality associated with the use of metformin compared with sulfonylurea monotherapy in type 2 diabetes. Diabetes Care 2002; 25:2244-8.
- Bell DS. Do sulfonylurea drugs increase the risk of cardiac events? CMAJ 2006; 174:185-186.

¿De verdad este doctor me está mandando a decir cómo debo tratarla? pensé. Cuando esto ocurre, sé que no es culpa del médico, sino de la academia. Y del ego. El paciente se siente mejor, se quita la grasa abdominal, mejora la glicemia con uso de menos medicinas (lo más irrefutable y contundente de que estamos en el camino correcto), pero aun así los médicos guiados por la academia sienten que deben hacer resistencia. "Eso no está bien", piensan. "Mi organización dice que hay que comer arroz. Yo digo que hay que comer arroz. Tengo 40 años diciendo que hay que comer arroz. Son 40 años de trayectoria diciendo que los pacientes con diabetes, descompensados o con sobrepeso, deben comer arroz. Y cuando voy a los congresos hablo frente a médicos que me aplauden y me hacen preguntas. Yo sé lo que digo. Usted debe comer arroz, y tomar medicinas que infartan para bajar el azúcar que le sube más allá de 140 mg/dl después del arroz. Porque de lo contrario, usted perderá músculo y no grasa". ALTO. Aquí está el error. ¿Lo recuerda? Fue explicado en los párrafos anteriores. Por favor, vuelva a leerlos. Los vegetales son carbohidratos. Los granos, tubérculos y frutas, carbodrogas.

La insulina evita que el hígado produzca azúcar. Pero su hígado "no escucha a su insulina". Es cada vez más resistente a ella porque cada vez tiene más barriga y en consecuencia produce más azúcar

¿Significa que un paciente con diabetes no podrá o deberá nunca consumir granos, tubérculos o frutas? No. No significa eso. Claro que podrá. Pero con la glicemia controlada (por debajo de 100 en la basal y de 140 en la postprandial) y sin medicinas que engordan o aumentan el riesgo cardiovascular, cuando desee hacerse esporádicamente, y también sin grasa en el abdomen o barriga (hígado graso, síndrome metabólico), cuando desee hacerse diariamente. El protocolo para lograr dicho estado, por demás ideal, se encuentra detallado en el capítulo que hemos dedicado al tratamiento. Por ahora, revisemos el siguiente estudio de 2 años de duración, en el cual se deja claro que las dietas bajas en carbohidratos son superiores a las bajas en grasa para evitar problemas infartos y accidentes cardiovasculares.

Ver:

http://www.annals.org/content/153/3/147.short

Las carbodrogas son el inicio y el final de la enfermedad. Las academias sugieren indicaciones equivocadas. Y lo peor, hacen de médicos bien intencionados, seguidores acéfalos. Porque prefieren no razonar a reconocer que llevan 40 años equivocados. Fue el caso de un muy reconocido endocrinólogo a quien lo llamaron aparte en un entierro para presentarle un caso de éxito. Le

llamaremos CC. La persona en cuestión había logrado normalizar su tensión, botar un cálculo del riñón y desaparecer el insomnio, con una dieta baja en carbodrogas y tomando magnesio. Aquel hombre no hacía más que hablar del milagro. De pronto, uno de los escuchas llamó al doctor CC y lo presentó. "¿Sabes quién es éste? Uno de los mejores médicos del país. Nos está contando sobre las bondades del magnesio", le explicaba mientras integraba a CC. "¿Tú tomas magnesio?" Lo increpa el médico. "Sí". "¿Y quién te mandó eso?" "Un médico". "Por favor… eso del magnesio no es cierto. Y además, no existe ni un estudio serio sobre el tema". Otra vez ALTO. Aquí nuevamente el problema. Hay estudios serios y publicados por centenas. No decenas, centenas. Para quien esté interesado en ellos, aquí el título de un texto que los recopila en buena medida: New Perspectives in Magnesium Research: Nutrition and Health. Estudios que, como hemos dicho, para el médico con experiencia, no son necesarios. Pero para aquél sin estudios ni experiencia, serán el punto de partida. Sin embargo, no todos somos como CC. Mantener la siempre adolescente actitud de "prefiero tener la razón por encima del éxito de mis pacientes", no es común entre nosotros los médicos. Podemos estar equivocados. Ese no es el problema. El problema es escuchar la evidencia, y ni siquiera considerar estarlo para corregir. La mejor prueba científica de que el magnesio y la suspensión de

carbodrogas funciona es, repito, un paciente enérgico, con aumento de su masa muscular, con su hemoglobina glicosilada A1c corregida, sin extremidades adormecidas, sin insomnio, sin taquicardias, sin dolores de cabeza y con la memoria de regreso. No lo que dice la academia. O el ego de un doctor. Lo que manda es lo que dice el cuerpo humano. Que no cambia. No como las pautas de la academia. Que todos los años cambian. La diabetes seguirá comiéndonos hasta el día en que comprendamos que somos nosotros quienes la comemos primero.

Sólo para médicos

Un tercer y penúltimo comentario. Hemos dicho que la neoglucogénesis es la fuente principal de energía en aquellos con paleo genoma. No los carbohidratos. La neogluogénesis. Que produce los carbohidratos que el cuerpo necesita, a partir de las proteínas de la dieta. Pero lo que no hemos dicho es que este escenario produce cetosis en ciertas ocasiones, la cual, contrario a la creencia médica, es un estado ideal.

Effect of Ketogenic Mediterranean diet with phytoextracts and low carbohydrates/high-protein meals on weight, cardiovascular risk factors, body composition and diet compliance in Italian council employees.

Antonio Paoli, Lorenzo Cenci and Keith A Grimaldi

For all author emails, please log on.

Nutrition Journal 2011,
10:112 doi:10.1186/1475-2891-10-112
Published: 12 October 2011

Abstract (provisional).

Conclusions: The KEMEPHY diet lead to weight reduction, improvements in cardiovascular risk markers, reduction in waist circumference and showed good compliance.

Ya sabrá usted que lo único científicamente comprobado que desacelera el envejecimiento es comer poco. Dietas hipocalóricas. Lo cual siempre, sin excepción, produce cetosis. Aquí, nuevamente, se pone de manifiesto lo que era usual en la vida paleolítica. Largos períodos de ayuno por lo inconsistente que puede ser la cacería. Cuarto y último comentario. Consumir carbodrogas produce placer. Es difícil, para el paleolítico acostumbrado a consumirlas, evitarlas consistentemente. Y peor aún, producen adicción fisiológica. Preguntarse cómo superar el imperioso deseo del adicto, es válido. Pero lo que no es válido es que nosotros, los regentes de la salud, sigamos diciendo que forman parte de la dieta balanceada. No es verdad. No lo son. Lo son, pero de la dieta desbalan-ceada. Y decir lo contrario nos hace copartícipes de la pandemia que estamos viviendo. “Mi médico dice que los granos se necesitan para la energía”, es nuestra responsabilidad. Y la suya como médico el resolver este dilema. Si como profesional de la salud todavía lo tiene (son o no son sanas las carbodrogas en el paleolítico). Debemos tomar parte activa. No sirve que nos impresionemos ante el aumento desproporcionado de

la diabetes en el planeta y sigamos hablando bien de los granos y los tubérculos. Sirve que digamos la verdad. Y la verdad no es sinónimo de sinceridad. Pudimos haber estado equivocados y haber sido sinceros al mismo tiempo. Pero es hora de corregir. Hora de dar la vuelta. Porque la tenemos que dar. Porque los pacientes nos creen a nosotros. No a los instructores de un gimnasio. A nosotros. A usted y a mí (debo reconocer que la ADA hizo algunos cambios menores en cuanto a sus recomendaciones dietéticas para 2011. Por vez primera, descalifica a las harinas blancas. Sin embargo, esto para nada es suficiente. Hacer énfasis sobre granos, frutas y tubérculos como los alimentos que deben predominar en el 60% de la dieta del diabético, ha sido nuevamente un error colosal).

CAPÍTULO 4

¿Cuál es su grupo?

Grupo 1

Su diabetes apareció antes de los 60 años de edad, con sobrepeso.

Usted se la pasó "a dieta". Adelgazaba y volvía a engordar. "Yo soy sano", decía. "Mi problema es la ansiedad". Hasta que su azúcar salió alto. ¿Diabetes? Sabía que debía cuidarse, pero nunca que le iba a dar. No tan joven al menos. Después de todo, "siempre fue sano". Con algo de estrés y triglicéridos altos. Pero sano. Y su pastilla para la tensión. Y el hígado graso. Pero de sentirse mal, nunca. Ahora debe perder peso, pero con "pastillas para el azúcar". Porque lo controla, o pierde la vista, los riñones y hasta el corazón. ¿El problema? Sigue atrapado por la "ansiedad de harinas y dulces". El Grupo 1 presenta obesidad y frecuentemente manchas o verrugas en la nuca (acantosis nigricans), ovarios poliquísticos, "retención de líquido" y tensión alta, antes del diagnóstico. Este grupo nunca debe recibir insulina indefinidamente (cuando se diagnostica a tiempo). De recibirla, sería sólo a manera de rescate. Sin embargo, es frecuente verlos "con insulina de por vida" porque "con

pastillas nunca se controlaron". En este escenario, aumentan de 10 a 15 kilos de grasa por año. Y su glicemia nunca se controla. Tienen riesgo moderado de cirrosis hepática, y el más alto de los grupos de presentar cálculos en el riñón, herniaciones lumbares, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Sin embargo, también es el grupo con mayor probabilidad de curar la diabetes con el protocolo expuesto en el capítulo 5. Utilizando el tratamiento de las "academias", el paciente engorda y empeora, hasta perder masa muscular. Convirtiéndose en paciente del Grupo 3.

Grupo 2

Su diabetes apareció después de los 60 años de edad.

Vio su cuerpo acumular grasa en la cintura. Su potencia sexual, su energía y su visión, sufrieron "con la edad". Sin embargo, la mala memoria era lo que lo asustaba. Hasta que vio su "azúcar" alto. ¿Diabetes? Sí, pero nuevamente "de la edad". ¿Por qué si usted come sano? Le pusieron tratamiento y lo mandaron al dietista. Y ahora, cada vez que regresa, no hacen más que mandarle otra pastilla. Que si una para el colesterol. Que si otra para la osteoporosis. Que si esta para dormir, que si aquella para el dolor.

Usted parece una farmacia. ¿Y su glicemia? Frecuentemente controlada. Este es el grupo que, dejado con el protocolo de las “academias”, mejor controla la glicemia, pero que más sufre de los “problemas de la edad”. Y que con el nuestro, podría contar con excelente salud.

Grupo 3

Su diabetes apareció antes de los 60 años de edad, delgado y con barriga.

Tal vez se inyecta insulina. Y el aumento de peso, las bajas de azúcar y el mal humor, le dominan la vida. No puede ser, razona, que lo único que hagan sea aumentarle la dosis. Y si no se inyecta, es el músculo lo que le preocupa. Usted era delgado. Pero no así. Antes tenía músculo. Delgado y con barriga, pero con brazos y piernas. O como decía, engordaba “de arriba”. Con el “caucho” en la cintura. Hasta que perdió su tamaño. Repentinamente. Y “empequeñeció”. Aquellos del Grupo 3 con menos de 5 años de “azúcar alto” frecuentemente escapan a esta regla. Este es el grupo que para el día del diagnóstico cuenta con la menor cantidad de páncreas funcional (falso Grupo 2), y con el tiempo, el que más

riesgo de cirrosis hepática, ceguera, infarto y ACV tiene. En el sexo femenino, son frecuentes las migrañas, el insomnio, las taquicardias, el hipotiroidismo, la fibromialgia, y los ovarios poliquísticos antes del diagnóstico. Y en el sexo masculino, la tensión alta, la impotencia y el mal humor. Es también el grupo que más cambios de tratamientos sufre a lo largo de la enfermedad, y el que gozará de una vida sana y vital con el diagnóstico temprano y el tratamiento correcto.

CAPÍTULO 5

Protocolo de Reversión de Diabetes 2 Dr. Johnson

Para **controlar** su diabetes usted deberá:

- Mantener la glicemia en ayuno bajo 100 mg/dl.
- Mantener la glicemia a las dos horas de las comidas bajo 140 mg/dl.
- Mantener la Hemoglobina Glicosilada A1c bajo 6,5%.

Para **revertir** su diabetes usted deberá:

1. Atacar la inflamación de su hígado.
2. Preservar su reserva pancreática.
3. Eliminar grasa abdominal.
4. Atacar su deficiencia de magnesio.
5. Preservar masa muscular.
6. Evitar los fármacos que aumentan la mortalidad.

Manual sólo para médicos

"Atacar la consecuencia de la diabetes,
la controla.
Atacar su causa,
la revierte".

Generalidades

El protocolo para frenar, revertir y curar la diabetes no insulinorrequiriente que se expone en el presente texto, no sigue, ni pretende seguir, lineamientos dictados por la Asociación Americana de Diabetes o Endocrinólogos. Sigue, sí, y muy a pesar de estas instituciones, los lineamientos de la medicina basada en evidencia, que como habrá visto a lo largo del texto, ha sido publicada por médicos tan médicos, valga redundancia, como los que acreditan estas academias. Queda claro entonces que la información aquí descrita no es mérito ni de su autor, ni de un selecto grupo de autores, sino que se trata, por el contrario, de información científica ampliamente conocida por el mundo médico, resumida en las siguientes premisas. En primer lugar, la existencia de 3 tipos de pacientes muy bien diferenciados entre sí, todos con diabetes no insulinorrequiriente para el momento de su debut, pero todos con fisipatología, retos y tratamientos también diferentes. A saber, un primer grupo obeso y con diabetes antes de los 60 años, un segundo grupo con diabetes después de los 60 años, y un tercer grupo con diabetes, delgado y con grasa en la cintura también de

aparición anterior a los 60. Indicar el tratamiento de un grupo en otro, es acelerar el desarrollo de la diabetes aun habiendo controlado su glicemia. Esto es, medicar un paciente del Grupo 1 como si fuera del Grupo 3, por citar un ejemplo. En segundo lugar, este protocolo basa sus fundamentos bajo la premisa de que para la diabetes Tipo 2, la Metformina es el fármaco de mayores beneficios, seguido de los inhibidores de la DPP 4, Sitagliptina y Vildagliptina. Las Sulfonilureas y las Tiazolidinedionas aumentan el riesgo a infarto, y al sobrepeso y la osteoporosis en el caso de las últimas. Las Sulfonilureas son un recurso terapéutico que debe ser utilizado única y exclusivamente por períodos menores a un año consecutivo. Cuando la dieta (evitando ingerir carbodrogas), la actividad física, el magnesio, la Metformina, y los inhibidores de la DPP 4 controlan la glicemia, ni las Sulfonilureas, ni las Tiazolidinedionas, ni la insulina, deben ser utilizados en el esquema terapéutico. La insulina no es el final común del paciente con diabetes, pero cuando está indicada, no deberá buscarse sustituto. Si al evitar la ingesta de las carbodrogas se evita la insulina, la insulina y las carbodrogas deben ser evitadas. Si en el paciente sin sobrepeso, al consumir granos, tubérculos y frutas, la glicemia sólo se controla con la toma de Sulfonilureas, y el paciente ya toma el esquema completo de Metformina y Sitagliptina o Vildagliptina, las Sulfonilureas podrán ser

utilizadas cuando estos alimentos sean ingeridos (máximo 3 veces por semana o con actividad física). Si la insulina produce hipoglicemia en una dieta sin carbodrogas, la insulina deberá ser disminuida o retirada, excepción hecha del paciente por debajo de su peso ideal (no deberá aumentarse la frecuencia o cantidad de la ingesta de carbodrogas salvo que esté bajo su peso ideal).

En otro orden de ideas, un paciente a sus 45 años se beneficiará con mantener su Hemoglobina Glicosilada inferior a 6,5% desde temprano, porque, como bien sabemos, así evitará la micropatía diabética. Inclusive, mientras más bajo el valor, mejor para el paciente. En él o ella, ser agresivo con la terapéutica desde el inicio tiene sentido. Más aún si es del Grupo 3. Por ello, en este protocolo iniciamos el esquema de insulina en todo paciente del Grupo 3, que aún teniendo la Hemoglobiba Glicosilada en rango, todavía después de 6 meses de iniciado el programa, eleva la glicemia más allá de 140 mg/dl a las dos horas de las comidas. La "luna de miel" en la que el páncreas del Grupo 3 todavía no se ha glicosilado o destruido, es importante aprovecharla. Y no esperar una Hemoglobina Glicosilada por encima de 8% en pacientes (repito, aquellos del Grupo 3) que para entonces ya habrán perdido más de la mitad del páncreas. Sin embargo, ésta no es la conducta que debemos tener con nuestros pacientes de mayor edad (Grupo 2). En aquel con 80 años es preferible una Hemoglobina glicosilada de

7,5%, a intentar bajarla con fármacos que podrían producir, a la larga, mayores problemas (hipoglicemias y aumento de peso con sus respectivos dolores de espalda), que beneficios (preservar un páncreas que siempre tiene reserva para cubrir los pocos años restantes).

¿Cómo destetar a su paciente de los betabloqueantes?

Elimine las carbodrogas de su dieta.

Toda vez que lleve una semana con Metformina 500 mg en el desayuno y 1.500 mg en la cena, indicar 500 mg de óxido de magnesio con el almuerzo.

Se sugiere el almuerzo porque es el momento menos probable en el que se estaría tomando el beta-bloqueante.

Si se toma el betabloqueante en el almuerzo, escoja otra comida para el magnesio.

Si el paciente presenta evacuaciones blandas, cambie el magnesio a 100 mg de magnesio Chelate.

Luego de una semana suplementándose con magnesio, y todavía sin consumir carbodrogas (cumpliendo la dieta paleolítica), proceda a disminuir a la mitad la dosis del betabloqueante. Si su paciente presenta tensión baja, elimínela completamente y sustituya su toma por los 500

mg de magnesio en ese mismo horario.

Evalúe diariamente su tensión arterial y la presencia o no de arritmia y taquicardia. Retome el betabloqueante si aparecen éstas, y si se eleva la tensión arterial, prescriba una de tantas opciones de antihipertensivos que existen en el mercado, y que no compiten con el magnesio (no los inhibidores de los canales de calcio).

Por el contrario, si la tensión arterial y la frecuencia cardíaca se mantienen dentro de la normalidad, elimine el betabloqueante completamente durante la segunda semana y evalúe la respuesta.

¿Qué hacer si su paciente sufre de la neuropatía diebética?

Si el paciente presenta la neuropatía diabética, indicar Gabapentina de 300 hasta 3000 mg. al día o Pregabalina de 150 hasta 600 mg. al día según tolerancia y respuesta terapéutica. Si el dolor persiste, agregar Duloxetina 60 mg. al día, y esperar dos semanas. Si el dolor aún persiste, añadir Tramadol 210 mg. al día. Indicar Ácido Alpha Lipóico 600 mg. tres veces al día y Diclofenac Sódico gel al 1% de forma tópica, según conveniencia.

¿Con qué debe suplementar a su paciente, con calcio o con magnesio?

Es frecuente recibir pacientes tomando Calcio "para evitar la osteoporosis". Esto, en aquellos que ya consumen de 600 a 800 mg de Calcio con la dieta diaria es un error. Suplementarse con Calcio cuando ya se consume, no sólo no evitará la osteoporosis, sino que aumentará el riesgo, nuevamente, a tener un infarto o un accidente cardiovascular.

Ver:

http://www.bmj.com/content/341/bmj.c3691.full

Ingerir más calcio del deseado altera la relación calcio-magnesio. No porque el calcio es malo y el magnesio es bueno. Sino porque la óptima relación calcio-magnesio debe prevalecer. Ponga atención, por ejemplo, en su paciente migrañoso que toma calcio. Suele abandonarlo porque sus dolores empeoran. O en aquel con taquicardias o insomnio, a quien le sucede igual. Condiciones éstas que

acusan el desequilibrio calcio-magnesio a favor del calcio, y que al consumirlo en forma de suplemento empeora la relación. Para evitar la osteoporosis, lo que hace falta es que el calcio no abandone los huesos. Y para ello se debe contar con magnesio. La osteoporosis no es una enfermedad por falta de calcio. La osteoporosis, en nuestro mundo moderno, es una enfermedad por desmineralización del hueso (o deficiencia de magnesio, como bien describe el siguiente estudio).

Ver:

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/135908491(

En este sentido, tomar calcio con magnesio no es tomar magnesio (se mantiene la misma relación). El insomnio, la taquicardia o el dolor de cabeza sólo mejorarán suspendiendo la pastilla de calcio con o sin magnesio, y suplementándose nada más con magnesio. Tema de vital importancia en quien ya está betabloqueado (tomando Inderal, Propranolol, Atenolol, Blokium, Concord, Ziaac o medicado con inhibidores de los canales de calcio) para evitar taquicardias o hipertensión, y a quien podría bajarle la tensión si le indicamos el magnesio (por sinergia con estas medicinas). Dejar a este paciente sin magnesio, sin embargo, sería el camino seguro, como hemos explicado, a pesar de ya tener la tensión y las

taquicardias controladas, al infarto, el Alzheimer y el accidente cardiovascular. Por ello, el protocolo de administración de magnesio en el paciente batabloqueado que he desarrollado y expuesto anteriormente. Y finalmente, quisiera dejar el acento en la osteoporosis. No equilibrar la relación calcio-magnesio hará que el paciente “meta” su esqueleto y el calcio que consuma, poco a poco, en todos los órganos del cuerpo. Órganos de células vacías del inhibidor de los canales de calcio. El magnesio. Tal escenario está bien representado en la Hipocalcemia por Hipomagnesemia (todo paciente con calcio bajo en los exámenes de sangre debe hacernos pensar en falta de magnesio. No de calcio. No si, como suele ocurrir, el paciente ya lo consume diariamente de los alimentos). ¿Hipoparatiroidismo? Muy probablemente secundario a Hipomagnesemia. Indique magnesio y verá la PTH corregir.

¿Qué hacer si su paciente presenta adicción por harinas y dulces?

Contamos con Bupropión y Topiramato (marcas registradas Wellbutrin y Topamax, respectivamente). Si el paciente tiene obesidad, es imperativo que pierda peso, y frente a la operación bariátrica, estos fármacos son una muy buena segunda alternativa. Utilizarlos en casos extremos de ansiedad por la comida. Frecuentemente con uno solo basta para ayudar al paciente, pero no menos frecuente es necesitar ambos a la vez. Si no existe historia de convulsión, podemos iniciar con Bupropión. Si existe insomnio, mejor sería comenzar con Topiramato. ¿Dosis? Bupropión, 150mg. 10:00 am (y hasta una segunda cápsula a partir de la segunda semana si no hay respuesta). El Topiramato lo iniciamos con 25mg en la cena y aumentamos 25 mg semanalmente hasta ver respuesta, o hasta llegar a un máximo de 200 mg al día. Mayores dosis tienden a producir mucha somnolencia o lentitud. Un paciente promedio podría beneficiarse con 50 mg en el almuerzo y 50 mg en la cena. A otro le irían mejor los 100 mg en la cena. En esto, la ansiedad por harinas y dulces en horas de la tarde o de la noche es el criterio para decidir

la conducta. Y un paciente extremadamente ansioso por la comida, por ejemplo, estaría con ambas drogas a la vez. Visto junto al tratamiento para revertir la diabetes, el esquema terapéutico quedaría de la siguiente forma:

Desayuno

Metformina 500 mg.

Sitagliptina o Vildagliptina 50mg.

Si se inyecta insulina, reducir dosis a la mitad en todas las aplicaciones del día a partir del tercer día de iniciado este esquema. Retomar dosis completa si la glicemia empeora.

Media mañana

Bupropión 150 mg.

Almuerzo

Una tableta de magnesio óxido 250 mg, si en la noche toma algún betabloqueante o IECA.

Topiramato 50-100 mg.

Media tarde

Bupropión 150 mg.

Cena

Metformina 1500 mg.

Sitagliptina o Vildagliptina 50mg (opcional).

Una tableta 250mg óxido magnesio (dos si tiene síntomas de falta de magnesio) y no lo toma en el almuerzo.

Topiramato 50-100 mg.

¿Qué hacer si su paciente presenta fatiga aún con glicemia controlada?

Los pacientes con fatiga crónica muy frecuentemente tienen hipotiroidismo. En esto, bien vale la pena asegurarse de que el paciente esté óptimamente medicado, o bien descartar su diagnóstico. Para ello, habrá que solicitar no solamente exámenes de TSH, T4 Libre y T3 Libre, sino también Anticuerpos Anti TPO y Anti Tiroglobulinas, además del Cortisol am y la Prolacina. De resultar el TSH normal, pero con Anticuerpos positivos y con clínica sugestiva (frialdad de extremidades, incapacidad de sudar, piel reseca, uñas quebradizas, fatiga y/o depresión), se deberá considerar la prueba terapéutica con 25 mg de Levotiroxina Sódica, muy a pesar de la TSH en rango (sobre todo en aquellos con diagnóstico de fibromialgia). Por otro lado, en aquellos ya con el diagnóstico y tratamiento, y además con la TSH en rango, pero todavía sintiéndose mal (con signos y síntomas de Hipotiroidismo), se deberá tomar una de las siguientes conductas. Primera. Aumentar en un cuarto la dosis de Levotiroxina y evaluar la respuesta. Si es positiva y no aparece un nuevo insomnio, taquicardia o

sudoración excesiva, se habrá de solicitar un examen de calcio parcial en orina. De resultar normal, el paciente deberá mantener la nueva dosis a pesar de la “TSH pisada”. Segunda. Considerar la indicación de Triiodotironina o T3 Libre como parte del tratamiento. Un paciente que toma 100 mcg de T4 Libre (Levotiroxina Sódica), deberá bajar a 75 mcg y acompañar ésta con dos dosis de 12,5 mcg de T3 Libre (Cytomel, marca registrada). Esto es, media tableta de 25 mcg por la mañana y media por la tarde. Un buen número de pacientes obtienen respuesta clínica solamente con este tratamiento combinado (Armour es otra buena opción).

Grupo 1

Con diabetes 2 antes de los 60 y con sobrepeso

Riesgo leve
Alzheimer.
Cáncer.
Retinopatía diabética.

Riesgo moderado
Infarto al miocardio y ACV.
Infertilidad (mujeres).
Cirrosis hepática.

Riesgo severo
Cálculos en los riñones.
Insuficiencia renal.
Insuficiencia cardíaca.

Errores frecuentes del tratamiento médico de las

“academias”

Falla al aumentar la resistencia hepática a la insulina (origen del problema), al engordar al paciente con carbodrogas después de las 10:00 am. Desconoce que los pacientes del Grupo 1 no engordan porque comen mucho o adelgazan porque comen poco. Engordan porque disparan la insulina mucho y adelgazan porque disparan la insulina poco. La pregunta no es cuántas calorías tiene una comida. La pregunta es cuánta insulina dispara una comida. Las harinas, los granos, las frutas y los tubérculos disparan la insulina mucho. Aun cuando el paciente del Grupo 1 controla su glicemia, si no está adelgazando la barriga, está empeorando la enfermedad. Esto, porque el Sd. Metabólico seguirá su curso. En este sentido, las carbodrogas podrán entre ellas ser estratificadas de mayor a menor índice glicémico. No importa. Igual todas disparan mucho la insulina.

Falla al no indicar de 1.500 a 2.000 mg de Metformina en horas de la noche (no de liberación prolongada) necesarios para inhibir la neoglucogénesis nocturna aumentada en su totalidad (es frecuente que indiquen la mitad de la dosis requerida o terapéutica).

Falla al indicar Sulfonilureas y o Insulina indefinidamente, que además de no ser necesarias en el Grupo 1 (únicamente podrían serlo de rescate), a la larga aumentan el riesgo cardiovascular y producen episodios

de hipoglicemia/hambre/engorde que aumentan la resistencia hepática a la insulina (origen del problema). Particularmente con la insulina, es frecuente escuchar sobre estudios publicados que mostraron beneficios en aquellos iniciados en el esquema tempranamente. Esto es cierto. Pero únicamente en aquellos del Grupo 3. Correcto en pacientes fisiopatológicamente opuestos a los del Grupo 1. Estos (los del Grupo 1) tienen mucha neoglucogénesis y mucha reserva pancreática. Aquellos (los del Grupo 3), poca neoglucogénesis y poca reserva pancreática. Incluir la insulina "tempranamente" en un paciente del Grupo 1 porque su HbA1c es superior a 8 y ha fallado al tratamiento con medicación oral, cuando no se le ha indicado los 2.000 mg de Metformina por la noche y no se han retirado las carbodrogas de la dieta, es un error de colosales dimensiones que la medicina clásica frecuentemente comete. Y lo comete porque no sabe cómo corregir la glicemia de otra manera. Pues aquí está "la manera": RETIRANDO LAS CARBODROGAS DE LA DIETA E INDICANDO 2.000 MG DE METFORMINA EN HORAS DE LA CENA. El único escenario en el que esto no será posible será en la insuficiencia renal (contraindicación de la Metformina). Pero seguir pensando en los pacientes diabéticos en función de su Hemoglobina Glicosilada y no en función de su grupo, es desconocer la solución al problema, además de interpretar equivocadamente no sólo éstos sino cualquier estudio

futuro sobre la insulina. La manera como un paciente sale o revierte su diabetes es por donde entró en ella. La diabetes es un cuarto de una sola puerta, y la salida es siempre por la entrada, diríamos. Aquellos con poca reserva pancreática hacen la diabetes por falta de insulina, por ello responden mejor, y preservan el páncreas mejor, indicando la insulina tempranamente. No así aquellos del Grupo 1. Quienes hacen la diabetes por mucha neoglucogénesis secundaria a mucha resistencia hepática a la insulina. Sin embargo, es comprensible, en el médico no experto, que opte por la salida equivocada. ¿Cómo va a proceder con la solución, cuando su propia academia le prohíbe retirar las carbodrogas?

Falla al no indicar suplementos de magnesio, con o sin medicamentos que botan magnesio, con o sin pastillas de calcio que evitan su función aumentando la taza de cálculos renales, hipertensión, trombos y calcificación arterial.

Falla al indicar anticonceptivos de manera indefinida.

Falla al indicar 6 porciones de comida al día como algo necesario.

Ventaja del Grupo 1 frente a los otros Grupos

Cuenta con mucha reserva pancreática.

Desventaja del Grupo 1 frente a los otros Grupos

Cuenta con mucha neoglucogénesis hepática nocturna (presenta mucha resistencia hepática a la insulina, lo que hace que produzca mucho azúcar, evitando la pérdida de peso en el mejor de los casos y engordando en el peor. Un círculo vicioso).

Solución

Aumentar su sensibilidad hepática a la insulina (retirando carbodrogas e indicando Metformina).

Ventajas del protocolo de reversión en el Grupo 1

Si se inyecta insulina o toma sulforinúreas, libera al paciente de éstas al controlar la glicemia sin requerirlas, haciéndole posible lo que con ellas nunca es posible: Perder grasa abdominal y en consecuencia aumentar la sensibilidad hepática a la insulina. Única vía para la reversión de la Diabetes Tipo 2 en el Grupo 1.

Indica 2.000 mg de Metformina en una sola toma nocturna, necesarios para inhibir la neoglucogénesis hepática propia del Grupo 1 (la cual es independiente de la ingesta), necesarios para revertir el síndrome metabólico en el cual el paciente se encuentra inmerso, aun con la glicemia controlada.

Evita o desteta al paciente de los betabloqueantes que estimulan la diabetes, suplementándolo con lo que verdaderamente el organismo requiere: magnesio.

La insulina en el protocolo de reversión del Grupo 1

La insulina será indicada única y exclusivamente como insulina de rescate. Cuando los pacientes del Grupo 1 utilizan el protocolo de reversión de la diabetes, nunca requieren insulina de manera permanente

Protocolo de reversión para el Grupo 1

Primera semana

Desayuno

Carpaccio de salmón con huevo rallado y alcaparras. Panquecas de harina de almendras con cacao y mermelada de fresa con edulcorante (sin azúcar). Huevos, jamones y todos los embutidos preparados en todas sus formas. Jugos verdes si no tiene apetito o costumbre de desayuno.

Medicinas

Metformina 500 mg + Sitagliptina o Vildagliptina 50mg (opcional). Si se inyecta insulina y o toma Sulfonilureas y o Tiazolidinedionas, reducir dosis a la mitad en todas las aplicaciones del día a partir del tercer día de iniciado el esquema (estas últimas eliminar completamente). Retomar si la glicemia empeora. Suspender completamente si se mantiene bajo 200 mg/dl.

Almuerzo

Carnes, pollo, pescados, embutidos, vegetales, aguacate, almendras, aceites de oliva y mayonesa al gusto. Si desea una pieza de chocolate negro y sin azúcar, gelatina de dieta.

Medicinas

De una a dos tabletas de magnesio óxido 250 mg si por la noche toma algún betabloqueante o IECA.

Cena

Sopas, vegetales y ensaladas con o sin aguacate. Gelatina sin azúcar.

Medicinas

Metformina de 1.500 a 2.000 mg.

Sitagliptina o Vildagliptina 50mg (opcional).

Una tableta 250mg óxido magnesio (dos si tiene síntomas de falta de magnesio y no lo toma con el almuerzo).

Media tarde y/o media mañana

Opcional. Combinado de almendras, carne de coco, nueces y avellanas (chocolate negro sin azúcar si desea dulce) a libre demanda.

Ejercicio

30 minutos de caminata diaria antes del desayuno. Buscar el trote cuando el peso lo permita.

Segunda semana

Desayuno

Agregar una taza de cualquier fruta o rebanada de pan integral, arepa o casabe. Evaluar la glicemia a las dos horas de la ingesta. Si se mantiene bajo 140 mg/dl, continuar intersemanal hasta adelgazar completamente. De lo contrario, mantener el plan de la Semana 1 hasta lograr el objetivo.

Medicinas

Mantener las de Semana 1. Si se inyecta insulina y redujo dosis a la mitad, evaluar glicemia a las 2 horas de las comidas. Eliminar completamente si la glicemia se mantiene bajo 200 mg/dl. Agregar Glibenclamida 5mg o Glimepiride 2 ó 4 mg si la glicemia se mantiene sobre 160 mg/dl. (sin insulina). Evaluar mensualmente con menos grasa abdominal. Retirar cuando corrija.

Almuerzo

Igual a la Semana 1.

Medicinas

Una tableta de magnesio óxido 250 mg si en la noche toma algún
betabloqueante o IECA

Cena

Carnes, pollo, pescados, embutidos, vegetales, aguacate, almendras, aceites de oliva y/o mayonesa al gusto. Una pieza pequeña de chocolate negro y sin azúcar, gelatina de dieta.

Medicinas

Mantener la de la Semana 1.

Media tarde y/o media mañana

Opcional. Combinado de almendras, carne de coco, nueces, avellanas (chocolate negro sin azúcar si desea dulce) a libre demanda.

Nota

Alternar Semana 1 y 2 hasta eliminar obesidad o sobrepeso completamente. Puede agregar una comida libre al almuerzo (con carbodrogas) el día del cambio, con glicemia controlada y a partir de las cuatro semanas de iniciado el tratamiento.

Grupo 2

Con diabetes 2 después de los 60 años

Riesgo muy leve con el tratamiento médico convencional
Cirrosis hepática.
Retinopatía diabética.
Neuropatía diabética.

Riesgo moderado con el tratamiento médico convencional
Infarto al miocardio.
ACV.
Insuficiencia cardíaca y renal.

Riesgo severo con el tratamiento médico convencional
Cáncer.
Alzheimer.
Osteoporosis.

Errores frecuentes del tratamiento médico de las "academias"

Falla al indicar Sulfonilureas en estadios en los que se produce hipoglicemias, que aumentan la resistencia hepática a la insulina al engordar al paciente por ingestas urgentes de azúcar.

Falla al indicar Sulfonilureas que aumentan el riesgo cardiovascular diariamente por más de un año consecutivo (dicho de otro modo, falla al no limitar, a un máximo de 3 días por semana, granos, frutas y tubérculos, motivo por el que se hace necesario indicar medicamentos que aumentan el riesgo cardiovascular más de tres veces por semana).

Promueve infartos, accidentes cardiovasculares y Alzheimer, al indicar suplementos de calcio cuando el paciente ya consume 800 mg en la dieta diaria (desequilibran la relación calcio-magnesio intracelular) y olvida suplementar al paciente con magnesio.

Promueve la diabetes al indicar betabloqueantes que deprimen la tiroides, estatinas que aumentan la glicemia y roban el 5% de la masa muscular anual, y los psicofármacos que engordan y potencian la diabetes (aumentan la resistencia hepática y muscular a la insulina).

Falla al olvidar suplementar al paciente con Vitamina B12 (70% de aquellos con más de 70 años de edad son deficientes en esta vitamina y la Metformina inhibe su absorción), pues la Vitamina B12 es necesaria para controlar la Homocisteina frecuentemente elevada en este grupo, marcador serológico que eleva el riesgo para desarrollar Alzheimer.

Falla al olvidar suplementar al paciente con Ácido Alpha Lipóico (el más importante antioxidante con el que cuenta la célula para combatir la glicosilación, pero deficiente en el diabético) y con magnesio.

Ventaja

Si se preserva su masa muscular y el paciente no aumenta su grasa abdominal, cuenta con suficiente reserva pancreática como para llevar una vida saludable. Su neoglucogénesis hepática es moderada.

Desventaja

El paciente es frecuentemente polimedicado para controlar síntomas por falta de magnesio y la ingesta de carbodrogas, que terminan engordándolo y robándole masa muscular. Ambas características necesarias para evolucionar su diabetes a una dependencia de insulina cada vez mayor.

Ventajas del protocolo de reversión del Grupo 2

Desteta al paciente de las medicinas que roban masa muscular y "engordan/aumentan glicemia/resistencia hepática y muscular a la insulina", evitando que el paciente se convierta al Grupo 3.

La insulina en el protocolo de reversión para el Grupo 2

Es muy poco frecuente que un paciente del Grupo 2 llegue a requerir insulina como parte del tratamiento indefinido. Cuando ocurre, se trata de un paciente del Grupo 3, a quien le diagnosticaron la diabetes tardíamente, después de los 60 años (de 15 a 20 años más tarde de su inicio). Por ello es frecuente que la población contemporánea cuente con familiares a quienes les diagnosticaron la diabetes a los 60, y que a los 65 usaron la insulina. En realidad, son pacientes a quienes se les mantuvo por años con la glicemia elevada desde mucho antes de los 50 años de edad. Por ello, todo paciente insulinorrequiriente del Grupo 2 deberá ser reevaluado debido a un error que lo engorda y, en consecuencia, aumenta la posibilidad de hígado graso y resistencia hepática a la insulina, o como un paciente correctamente medicado, pero que en realidad pertenece al Grupo 3.

Protocolo de reversión del Grupo 2

Primera semana

Desayuno

Carpaccio de salmón con huevo rallado y alcaparras. Panquecas de harina de almendras con cacao y mermelada de fresa edulcorada (sin azúcar). Huevos, jamones y todos los embutidos preparados en cualquier forma. Jugos verdes si no tiene apetito o costumbre del desayuno.

Medicinas

Metformina 500 mg − 1.000 mg + Sitagliptina o Vildagliptina 50mg. Si se inyecta insulina o toma Sulfonilureas y o Tiazolidinedionas, y su glicemia está controlada (si se mantiene bajo 140 mg/dl a las dos horas del desayuno), hay que suspender completamente. De lo contrario, reducir a la mitad todas las tomas, a partir del tercer día del programa. Evaluar glicemia diariamente y retomar si empeora.

Almuerzo

Carnes, pollo, pescados, embutidos, vegetales, aguacate, almendras, aceites de oliva y mayonesa al gusto. Si desea, una pieza de chocolate negro y sin azúcar, gelatina de dieta.

Medicinas

De una a dos tabletas de magnesio óxido 250 mg si por la noche toma algún betabloqueante o IECA.

Cena

Sopas, vegetales y ensaladas con o sin aguacate. Gelatina sin azúcar.

Medicinas

Metformina de 500 a 1.000 mg. + Sitagliptina o Vildagliptina 50 mg. Una tableta 250 mg óxido magnesio (dos si tiene síntomas de falta de magnesio y no lo toma con el almuerzo). Vitamina B12 1.000 mg y Ácido Alpha Lipoico 300–600 mg intermensual.

Media tarde y/o media mañana

Opcional. Combinado de almendras, carne de coco, nueces, avellanas (chocolate negro sin azúcar si desea

dulce) a libre demanda.

Ejercicio

30 minutos de caminata diaria antes del desayuno. 30 minutos de ejercicio de resistencia tipo pesas, máquinas o ligas, de 3 a 5 veces por semana.

Segunda semana

Desayuno

Si la glicemia no está controlada, se debe mantener el esquema de la primera semana. De lo contrario puede agregar una taza de cualquier fruta o rebanada de pan integral, arepa o casabe. Evaluar la glicemia a las dos horas de la ingesta. Si se mantiene bajo 140 mg/dl, continuar indefinidamente de acuerdo al gusto. De lo contrario, agregar o aumentar Glibenclamida 5 mg o Glimepiride de 2 a 4 mg, e intentar retirar mensualmente con más músculo y menos grasa abdominal.

Medicinas

Mantener las de la Semana 1. Si se inyecta insulina y redujo dosis a la mitad, evaluar glicemia a las dos horas de las comidas. Eliminar completamente si la glicemia se mantiene bajo 200 mg/dl. Agregar Glibenclamida 5 mg o Glimepiride 2 ó 4 mg si la glicemia se mantiene sobre 160 mg/dl (sin insulina). Evaluar cada 5 kilos menos y retirar cuando corrija.

Almuerzo

Si no tiene sobrepeso, puede agregar una taza de granos, pasta, plátano o frutas, siempre que la glicemia esté controlada (bajo 140 mg/dl a las dos horas de su ingesta) y hasta un máximo de tres veces por semana.

Medicinas

Agregar Glibenclamida 5 mg o Glimepiride 2 ó 4 mg si la glicemia se eleva sobre 140 mg/dl únicamente en las comidas con carbodrogas. Una tableta de magnesio óxido 250 mg si en la noche toma algún betabloqueante o IECA.

Cena

Carnes, pollo, pescados, embutidos, vegetales, aguacate, almendras, aceites de oliva y/o mayonesa al gusto. Una pieza pequeña de chocolate negro y sin azúcar, gelatina de dieta.

Medicinas

Mantener las de la Semana 1.

Media tarde y/o media mañana

Opcional. Combinado de almendras, carne de coco, nueces, avellanas (chocolate negro sin azúcar si desea dulce) a libre demanda.

Nota

Si tiene la glicemia controlada, mantener este esquema de por vida con hasta tres comidas libres semanales. Si aumenta la grasa abdominal, retomar la Semana 1.

Grupo 3

Con diabetes 2 antes de los 60 años sin sobrepeso

Riesgo leve con el tratamiento médico convencional
Cáncer

Riesgo moderado con el tratamiento médico convencional
Infertilidad (mujeres).
Cálculos en los riñones.
Insuficiencia renal.
Insuficiencia cardíaca.

Riesgo severo con el tratamiento médico convencional
Cirrosis hepática.
Retinopatía diabética.
Neuropatia diabética.
Nefropatía diabética.
Infarto al miocardio y ACV.

Depresión.
Osteoporosis.

Errores frecuentes del tratamiento médico de las "academias"

Falla al identificar al paciente 10 años después de iniciada la enfermedad, momento para el que ya ha se perdido más de la mitad del funcionamiento del páncreas por culpa del diagnóstico tardío.

Falla al no reconocer al hipotiroidismo cuando existe, aun con los exámenes de sangre en rango, propio del paciente con migrañas que no se eliminan con los suplementos de magnesio (si antes no se corrige el hipotiroidismo).

Falla al no indicar suplementos de magnesio en aquellos aún sin diabetes, pero con taquicardias, insomnio, migrañas y/o arenilla renal, propios de la falta de magnesio, que de no ser corregida, estimulan la resistencia muscular a la insulina, origen de la diabetes Tipo 2 del paciente Grupo 3.

Falla al no indicar la insulina tempranamente como parte del tratamiento, en aquellos que lo requieren.

Falla al no reducir o eliminar la dosis de insulina en el paciente que está presentando hipoglicemias, obligándolo

a consumir carbodrogas que lo rescaten de ellas, pero que lo engordan y aumentan la resistencia hepática y periférica a la insulina. Así se crea un círculo vicioso en el cual el mismo tratamiento empeora y gesta la diabetes.

Falla al no indicar suplementos de magnesio, con o sin medicamentos que botan magnesio, con o sin pastillas de calcio que evitan su función.

Falla al no indicar ejercicio de resistencia (pesas o máquinas).

Ventaja

Se puede identificar con un Test de Tolerancia glucosada a tiempo y controlar completamente.

Desventaja

Como dijimos, el paciente con diabetes del Grupo 3 es frecuentemente identificado de 10 a 15 años de iniciada la enfermedad (falso Grupo 2), momento para el que ya ha perdido más de la mitad del funcionamiento de su páncreas. Estos son pacientes con mucha resistencia muscular o periférica a la insulina desde la segunda década de la vida, muy a pesar de su delgadez, junto a una pobre reserva pancreática que deberán cuidar. Y aunque de poca neoglucogénesis hepática, para el momento del

diagnóstico (10 años más tarde), ya es frecuente que la tengan aumentada. En este sentido, el paciente que a los 45 tiene la glicemia postprandial elevada y la basal normal, tendrá a los 55 años ambas elevadas.

Solución

Identificar al paciente tempranamente, realizándole la HbA1c y el Test de Tolerancia Glucosada con 75 gr de glucosa vía oral, a los 0, 60 y 120 minutos a todos aquellos con glicemia basal normal, delgados y con barriga, que tengan entre 30 y 50 años de edad (frecuentemente con familiares diabéticos y/o síndrome de ovarios poliquísticos). Eliminar carbodrogas después de las 10:00 am, e iniciar tratamiento con Metformina y Sitagliptina o Vildagliptina, si la Glicemia a los 60 minutos es igual o superior a 150 mg/dl. O si la Hemoglobina Glicosilada A1c es superior o igual a 6,2% (puntos de corte del protocolo de cura y reversión).

Ver:

http://care.diabetesjournals.org/content/31/8/1650.full

No debemos esperar a tener la Glicemia superior a 140 mg/dl. a los 120 minutos o la HbA1c por encima de 6,5%, como lo hace la medicina convencional. Sólo de esta

manera se preservarán las células Beta del páncreas. Si a los 3 meses de iniciado el protocolo para el Grupo 3 la glicemia no corrige, iniciar esquema de insulina en aquel sin sobrepeso.

Grupo 3, el falso Grupo 2.

Los pacientes delgados y con barriga, cuya diabetes se inicia antes de los 60 años de edad (Grupo 3), elevan la glicemia únicamente a las dos horas de las comidas al inicio de la enfermedad. Eso ya lo hemos dicho. Esto es, nunca en el ayuno. Razón por la que sus exámenes de glucosa basal nunca avisan (tener la glicemia basal normal no garantiza no tener diabetes en aquel que es delgado, menor de 60, y con barriga). Dejado sin tratamiento, comenzará en unos 5 a 15 años a elevar la glicemia en ayuno, momento para el que frecuentemente le hacen el diagnóstico al paciente. Cuando se interroga por el inicio de su enfermedad, si es mayor a 60, podría hacernos pensar que es del grupo 2 (debutando después de los 60), cuando en realidad es del Grupo 3 (debutando delgado y antes de los 60). Ambos Grupos tienen protocolos muy distintos en el tratamiento. Aquellos del Grupo 2 cuentan con suficiente reserva pancreática. Los del grupo 3 no. Por ello, el criterio para indicar la insulina es en ambos muy distinto. Y un craso error llegarlos a confundir. Ya por retrasar su inicio, o indicarla cuando tan sólo traería problemas. En el

paciente que nos refiere el inicio de su diabetes a partir de los 60, pero que le vemos delgado, sin barriga (Falso Grupo 2), y que nos refiere 10 kilos menos en la última década, no debemos retardar el inicio de un esquema con insulina. Sin embargo, este mismo paciente, también con 10 kilos menos, pero todavía con sobrepeso, podríamos esperar, muy a pesar de una hemoglobina glicosilada superior a 10 inclusive, sin indicarle la insulina (verdadero Grupo 2).

Protocolo de reversión del Grupo 3

Primera semana

Desayuno
Carpaccio de salmón con huevo rallado y alcaparras. Panquecas de harina de almendras con cacao y mermelada de fresa edulcorada (sin azúcar). Huevos, jamones y todos los embutidos preparados en cualquier forma. Jugos verdes si no tiene apetito o costumbre del desayuno.

Medicinas
Metformina 500 mg. + Sitagliptina o Vildagliptina 50 mg. Si se inyecta insulina o toma Glibenclamida o Glimepiride, y su glicemia está controlada (si se mantiene bajo 140 mg/dl a las dos horas del desayuno), reducir a la mitad todas sus tomas, a partir del tercer día del programa. Eliminar completamente si a los tres días se mantiene bajo 90 mg/dl. Retomar si empeora. Si, por el contrario, la glicemia no está bajo 140 mg/dl, esperar tres días después de iniciado el programa y comenzar o

aumentar esquema de insulina.

Almuerzo

Carnes, pollo, pescados, embutidos, vegetales, aguacate, almendras, aceites de oliva y mayonesa al gusto. Si desea, una pieza de chocolate negro y sin azúcar, gelatina de dieta.

Medicinas

De una a dos tabletas de magnesio óxido 250 mg si por la noche toma algún betabloqueante o IECA.

Cena

Sopas, vegetales y ensaladas con o sin aguacate. Gelatina sin azúcar.

Medicinas

Metformina de 500 a 1.000 mg. Sitagliptina o Vildagliptina 50 mg. Una tableta 250 mg óxido magnesio (dos si tiene síntomas de falta de magnesio y no lo toma con el almuerzo). Vitamina B12 1.000 mg y Ácido Alpha Lipoico 300–600 mg diario e intermensual.

Media tarde y/o media mañana

Opcional. Combinado de almendras, carne de coco, nueces, avellanas (chocolate negro sin azúcar si desea dulce) a libre demanda.

Ejercicio

30 minutos de caminata diaria antes del desayuno. 30 minutos de ejercicio de resistencia tipo pesas, máquinas o ligas, de 3 a 5 veces por semana.

Segunda semana

Desayuno

Si la glicemia no está controlada, mantener el esquema de la primera semana. De lo contrario, puede agregar una taza de cualquier fruta o rebanada de pan integral, arepa o casabe. Evaluar la glicemia a las dos horas de la ingesta. Si se mantiene bajo 140 mg/dl, continuar indefinidamente. De lo contrario, aumentar o iniciar insulina.

Medicinas

Mantener las de la Semana 1.

Si se inyecta insulina y redujo dosis a la mitad, evaluar glicemia a las dos horas de las comidas. Eliminar completamente si la glicemia se mantiene bajo 140 mg/dl. Reducir si la glicemia corrige. Retirar si produce hipoglicemia.

Almuerzo

Si no tiene sobrepeso, agregar una taza de granos, pasta, plátano o frutas (carbodrogas), siempre que la glicemia esté controlada (bajo 140 mg/dl a las dos horas de su

ingesta) y hasta un máximo de tres veces por semana.

Medicinas

Aumentar o iniciar insulina si la glicemia se eleva sobre 140 mg/dl, únicamente en las comidas con carbodrogas.

Una tableta de magnesio óxido 250 mg si en la noche toma algún betabloqueante o IECA.

Cena

Carnes, pollo, pescados, embutidos, vegetales, aguacate, almendras, aceites de oliva y/o mayonesa al gusto. Una pieza pequeña de chocolate negro y sin azúcar, gelatina de dieta.

Medicinas

Mantener las de la Semana 1.

Media tarde y/o media mañana

Opcional. Combinado de almendras, carne de coco, nueces, avellanas (chocolate negro sin azúcar, si desea dulce), a libre demanda.

Nota

Si tiene la glicemia controlada, mantener este esquema de por vida hasta con tres comidas libres semanales. Si

aumenta la grasa abdominal, retomar Semana 1.

CAPÍTULO 6

Resumen

La diabetes 2 no es una enfermedad. Es una consecuencia.

La diabetes 2 es la consecuencia de ingerir alimentos anti paleolíticos contando con un metabolismo paleolítico.

Atacar la diabetes es atacar la consecuencia.

Atacar la alimentación y reponer el magnesio es atacar la causa.

La mitad de quienes tienen diabetes desconoce que la padece y sólo se enterará a los 10 años de iniciada la enfermedad. Es decir, tarde. Muy tarde.

La cura no es posible en la mayoría. La reversión si es posible en la mayoría. En muchos, la reversión implica la eliminación de medicinas con mejor control de glicemia. En otros, el alivio de un síntoma o evitar un mal mayor. Para lograrlo, debe conocer su grupo de diabetes 2 que resulta de la interacción entre la edad de su debut, la formación de azúcar por parte de su hígado (neoglucogénesis hepática) y el fallo del páncreas (reserva pancreática). Control, reversión y cura no son sinónimos. La reversión, sin embargo, incluye la cura en muchos del GRUPO 1.

La creatinina es el valor sanguíneo que mide la capacidad funcional de sus riñones. Si es igual o superior a 1,5 mg/dl, debe ir al nefrólogo. No debe tomar Metformina sin su consentimiento.

Si tiene hipertensión o insomnio o migrañas o antecedentes de cálculos en el riñón, usted debe suplementarse, en la cena y diariamente, con 500 mg de óxido de magnesio, no 250. Esto, si no presenta Miastenia Gravis, bradicardia o insuficiencia renal. Si toma calcio, deberá hacerlo en el desayuno (almuerzo si toma pastillas para la tiroides), única y exclusivamente porque su médico lo ha indicado. Y si toma medicinas para la tensión arterial, deberá hacerlo bajo supervisión médica.

Las grasas saturadas y el colesterol de la dieta aumentan el colesterol bueno.

Ver:

http://www.jci.org/articles/view/116375

Las grasas son buenas porque elevan el colesterol bueno (HDL), y a mayor colesterol bueno, menor riesgo de infarto. Como bien lo deja claro el siguiente estudio.

Ver:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21985949

Y a mayor colesterol bueno, menor riesgo de Alzheimer.

Ver:

http://www.medscape.com/viewarticle/734386

Las grasas saturadas disminuyen el riesgo a infarto y Alzheimer. Malo es freírlas. Pero el jamón serrano, por citar un ejemplo, es bueno para la salud. No diga que come sano porque come sin grasas saturadas. Las grasas, en general, y más enfáticamente las monoinsaturadas, conforman los ladrillos estructurales de las membranas celulares. Membranas que permiten la comunicación de éstas con el exterior. Consuma grasas monoinsaturadas como el aguacate, la almendra y el paté (si, el paté), y rejuvenezca su comunicación celular.

Las grasas de la dieta producen saciedad, lubrican el intestino y no disparan la insulina. No tapan su hígado, no forman su barriga y no tapan sus arterias. Las grasas que tapan su hígado, su barriga y sus arterias son los granos, las frutas los tubérculos, que al ingresar al organismo se mezclan con la insulina. Y se convierten en grasa tapa

hígado, tapa barriga y tapa arterias. Así que, por favor, usted que es paleolítico, no diga que come sano porque come sin grasa. Diga que come sano porque come sin granos, sin frutas y sin tubérculos. Al menos después de las 10:00 am. Y recuerde. Los vegetales son carbohidratos. Las frutas, para aquellos con metabolismo paleolítico y barriga, insisto, son vegetales malogrados. Estamos felices con las vitaminas, los minerales, la fibra y los antioxidantes de las frutas. Pero estamos tristes con el azúcar de las frutas. El azúcar, como hemos dicho, dispara la insulina. Y la insulina forma grasa, ateromas y es cancerígena. Si come vegetales, usted ya come frutas. No las necesita. Coma vegetales. No frutas. No después de las 10:00 am. O a cualquier hora, pero solo fresas.

Coma harinas, granos y dulces, y no aguantará la ansiedad por comerlos. Evítelos por 3 días, y no tendrá más ansiedad. Su problema no es la ansiedad por harinas y dulces. Su problema es la reacción bioquímica que estos alimentos producen y que se traduce en ansiedad. Use el aguacate a media tarde. Aprenda a preparar panquecas de almendras, pudines de almendras, mantequilla de almendras, panes de almendras. Aprenda a vivir con almendras. O nueces, macadamias o avellanas. Use el chocolate negro sin azúcar. Combine los alimentos. Pero no regrese a las carbodrogas como estilo de vida. Una vez por semana. De vacaciones. De cumpleaños. De navidad. Pero no se alimente habitualmente con ellas.

Si aún no maneja su ansiedad por ellas, y tiene barriga o la glicemia sin control, consulte a su médico por las siguientes dos alternativas terapéuticas. Topiramato y Bupropión.

La estatinas producen fatiga a nivel celular, roban 5% de la masa muscular anual, y estimulan la diabetes.

Ver:

http://www.bmj.com/content/343/bmj.d5004.extract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21995692

Los médicos indicamos las Estatinas para bajar el colesterol. No las use. Sólo si es estrictamente necesario. Discútalo con su médico. Aunque la evidencia sugiere que podrían darle una dosis baja porque producen diabetes únicamente con una dosis dependiente, usted ya tiene diabetes. Y usted la quiere revertir. Discuta con su médico si puede tomar ácido acetil salicílico. Se ha demostrado que el papel cardioprotector que confieren las estatinas se debe a su papel antiinflamatorio. No porque bajan el colesterol. El ácido acetil salisílico confiere esta misma ventaja. Y recuerde. El HDL es el colesterol bueno. Si es mujer y lo tiene alto, no use estatinas. En la mujer es lo que importa. El bueno alto. Y si el LDL

(colesterol malo) está alto, evalúe su tiroides. Bien. Los betabloqueantes ahora. Medicinas como el Propranolol y Atenolol. Estimulan la diabetes. Si las toma, evalúe junto a su médico la necesidad de utilizarlas. Existen opciones que pueden sustituirlos. Si toma psicofármacos como antiepilépticos y antidepresivos, evalúe si engordan y si los puede o no sustituir. Si toma Niacina o Vitamina B3, hágalo por períodos intermensuales (nunca de modo contínuo) y nunca por la noche.

La Metformina no permite la absorción completa de la Vitamina B12. Si está medicado con ella, supleméntese con Vitamina B12 500 mg y ácido fólico 400 mcg en el desayuno. Si tiene fatiga y se le cae el cabello, o su piel es reseca y tiene uñas quebradizas, tome Selenio 200mcg también con el desayuno. Sobre todo si tiene diagnóstico de hipotiroidismo por Hashimoto. Si sufre de dolores articulares y alteraciones con la evacuación, elimine lácteos y trigo completamente. Si no se ha hecho exámenes de tiroides o si "siempre salen bien", y se siente fatigado y no suda, vaya al laboratorio y solicite, esta vez, la TSH con los anticuerpos anti TPO y Antitiroglobulinas, la Prolactina, el Cortisol am y el Hierro sérico. Y llévelos a su doctor. Cuide su espalda. Guarde la postura. Y no le robe horas al sueño.

El "azúcar alto" del ayuno, ya le empatucó los órganos.

Bajar el “azúcar alto” por la mañana es llegar tarde.

El “azúcar alto” en el ayuno saca barriga.

Para revertir la diabetes, se debe quitar la barriga.

La barriga no se quita con cualquier dieta.

La barriga se quita tomando 1 g de Metformina con la cena, y evitando granos, harinas, frutas y tubérculos después de las 10:00 am.

La deficiencia de magnesio no se ve con exámenes de sangre.

La deficiencia de magnesio produce insomnio, taquicardia, hipertensión, dolores de cabeza, azúcar alto, fatiga y cálculos en los riñones. En consecuencia, estos signos y síntomas desaparecen tomando magnesio con el protocolo médico correcto.

Tomar medicinas para enmascarar alguno de los síntomas de falta de magnesio, sin tomar magnesio, produce infartos, accidentes cardiovasculares, depresión, calcificación arterial, osteoporosis, cálculos en los riñones y Alzheimer.

En la diabetes, 90% de los fallecidos por causa cardiovascular es por falta de magnesio.

Tomar calcio con magnesio no es tomar magnesio.

La forma correcta de controlar la glicemia después de las comidas no es con medicinas.

A más medicinas para controlar la glicemia, más tempranalamuerte(EstudioACOORD).

La grasa no engorda, no tapa arterias, no produce hígado graso, no eleva triglicéridos, y es buena para usted.

La grasa es un alimento anti diabetes porque libera GLP-1 a nivel intestinal igual que la Sitagliptina y Vildagliptina

La grasa saturada eleva el colesterol bueno.

A mayor colesterol bueno, menor riesgo cardiovascular.
Las frutas, los granos y los tubérculos son malos alimentos en aquellos con metabolismo paleolítico y barriga o grasa en la cintura.

Las frutas, los granos y los tubérculos son buenos alimentos en aquellos sin metabolismo paleolítico o con metabolismo paleolítico, pero con el azúcar controlado y sin barriga.

Las personas con diabetes tienen metabolismo paleolítico.

Las frutas, los granos y los tubérculos conformarían una dieta DESBALANCEADA en aquellos con metabolismo paleolítico con barriga y o azúcar descontrolado, que habría que “balancear” con medicinas.

Coma aguacate. Uno por día.

El hígado produce carbohidratos.

Si usted no come carbohidratos, pero tiene hígado, usted sí come carbohidratos.

Los carbohidratos no son esenciales o necesarios porque el hígado los produce a partir de las proteinas de la dieta.

Las proteinas de la dieta, son los carbohidratos del hombre paleolítico.
Las proteinas de la dieta son la energía del hombre paleolítico.

Si su glicemia se mantiene en control, aun consumiendo harinas, granos, frutas y tubérculos, y usted ni se inyecta insulina ni toma sulfonilureas, puede seguir ingiriéndolos siempre que no tenga barriga.

Si tiene barriga, debe limitarlos a un máximo de dos veces por semana.

Si tiene barriga, tiene hígado graso.

Si tiene hígado graso y se le inflama, tendrá de 5 a 10% de probabilidades de perder el hígado en 20 años.

Por ello debe quitarse la barriga.

Por ello, aun con la glicemia controlada, si tiene barriga debe limitar las harinas, los tubérculos, las frutas y los granos.

En nuestro protocolo Pare la Diabetes el 14 Días la idea es controlar rápidamente la glicemia. Para ello, desayunar durante la primera semana cualquier cantidad de almendras, macadamia, avellanas, nueces, huevos, jamones, carnes, pescados, café, aguacates y vegetales en general (no granos, no frutas, no jugos, no tubérculos, no lácteos y no harinas). Almuerzo y media tarde, refrescos de dieta y los mismos alimentos con o sin aceites, cremas, mayonesas y salsas (no teriyaqui, no miel, no salsa de tomate, y no barbecue). En la cena, los mismos alimentos respetando el apetito. La idea es llegar al quinto día con la capacidad de cenar únicamente vegetales, ensaladas y sopas, para evaluar la efectividad del tratamiento en dicho escenario. Agregar fruta (no jugo) o una rebanada de pan integral o una tortilla de maíz o una arepa o una hoja de casabe al desayuno, a partir de la segunda semana, siempre que la glicemia se mantenga bajo 140 mg/dl a las

dos horas de su ingesta. Si a partir de la segunda semana su glicemia basal no es inferior a 120 mg/dl, aumentar hasta 2.000 mg de Metformina con la cena. Si todavía no mejora, agregar 2 mg de Glibenclamida por tres meses. En este sentido, se sugiere medir la Glicemia basal durante 7 días para evaluar dicho tratamiento. Si su glicemia post prandial (a dos horas del desayuno, almuerzo o cena) es superior a 140 aun cumpliendo la dieta paleolítica, y ya tomando Metformina y Sitagliptina, agregar nuevamente glibenclamida y evaluar su necesidad en 3 meses. Si aun así su glicemia permanece elevada, discutir la necesidad de suministrarse insulina.

Si la glicemia post prandial en el almuerzo es inferior a 140 mg, y no se inyecta insulina, ni toma sulfonilureas en esta comida, puede agregar hasta una taza de granos o plátanos o frutas o cualquier almidón a partir de la segunda semana del tratamiento, y evaluar el valor de la glicemia (si toma sulfonilureas, elimínela y no agregue los nuevos alimentos). De elevarse, retírelos nuevamente, y aumente su masa muscular y disminuya su grasa abdominal en un 5%. Reinténtelo hasta alcanzar el objetivo. Si en 6 meses no lo logra y no tiene sobrepeso, discuta con su médico la posibilidad de recibir insulina. Si su glicemia se mantiene en control, salvo cuando ingiere almidones, discuta con su médico la posibilidad de tomar Glimepiride o Glibenclamida únicamente en dicho escenario (máximo 3 veces por semana). Este esquema le

asegura el control de la glicemia, y la no dependencia de medicamentos que, de tomarlos consistentemente, le harían daño.

La situación de su diabetes es proporcional a la aparición de las complicaciones crónicas de la enfermedad, a los resultados de su Hemoglobina Glicosilada A1c, a la situación de su tensión arterial, de sus lípidos, y de la presencia o no de Microalbuminuria en su examen de orina. Hágase esta prueba, llévela al nefrólogo.

Coma 60% verde. Vegetales y semillas. Y si quiere frutas diariamente, fresas. Contienen poco azúcar y están cargadas de Fisetina. Un flavonoide capaz de revertir la micropatía diabética.

Si le gusta el huevo, cómalo en todas sus formas. Es excelente en el desayuno. Yema incluida. No sube el colesterol. Todos los días si le apetece.

Visite al nefrólogo y al oftalmólogo una vez al año.
Revise sus pies semanalmente. Vea la planta con espejo si no puede sólo. Vaya al médico si descubre alguna lesión.

No negocie la actividad física. Haga ejercicios de resistencia. Es lo único que le preservará el músculo. El músculo es su único tejido antidiabetes. Cuídelo. Recuerde que, dejado a la inercia, perderá de 2% a 3% de

su masa muscular anual. Evítelo.

Escríbame un mail. Déjeme conocer como este libro le cambió la vida. Lo quiero mucho.

Table of Contents

Front Cover
Title Page
Copyright
Dedicatoria
Agradecimientos
A Usted Que No Lo Conozco
Introduccion
Capitulo 1
Capitulo 2
Capitulo 3
Capitulo 4
Capitulo 5
Capitulo 6